



Bunga Rampai

PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA

DALAM PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Rahmadani • M. Noor Ifansyah • Supriadi
Maratusholikhah Nurtyas • Herta masthalina • Nur Aini fatimah

Editor : Nur Fadhilah

BUNGA RAMPAI

PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA DALAM PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Penulis:

apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.
M. Noor Ifansyah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Drs. Supriadi, SKp., M.Kep., Sp.Kom.
Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes.
Dr. Herta masthalina, S.KM., M.PH.
Nur Aini fatimah, S.Kom., M.Kes.

Editor:

Nur Fadhilah, S.Kep., M.Kes., Ph.D.



BUNGA RAMPAI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA DALAM PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Penulis:

apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.
M. Noor Ifansyah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Drs. Supriadi, SKp., M.Kep., Sp.Kom.
Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes.
Dr. Herta masthalina, S.KM., M.PH.
Nur Aini fatimah, S.Kom., M.Kes.

Editor: Nur Fadhillah, S.Kep., M.Kes., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-81-3

Cetakan Pertama : Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku berjudul “Bunga Rampai Pelayanan Kesehatan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan” dapat disusun dan diselesaikan. Buku Bunga Rampai ini disusun sebagai bentuk kontribusi untuk memperkuat pemahaman dan penerapan pelayanan kesehatan yang humanis, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan nyata pasien dan keluarganya dalam berbagai setting layanan baik di rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun pelayanan berbasis komunitas.

Perubahan paradigma pelayanan kesehatan di era modern menempatkan pasien bukan lagi sebagai objek perawatan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak, nilai, preferensi, serta kapasitas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, keluarga merupakan sistem pendukung terdekat yang turut memengaruhi kepatuhan pasien, kontinuitas perawatan, serta keberhasilan proses penyembuhan. Oleh karena itu, pendekatan patient- and family-centered care menjadi semakin relevan untuk menjawab tuntutan mutu layanan, keselamatan pasien, etika profesi, dan perlindungan hak pasien. Pendekatan ini menekankan kemitraan yang setara antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga melalui komunikasi terbuka, penghormatan terhadap pilihan pasien, pemberdayaan keluarga, serta kolaborasi dalam setiap tahap pelayanan.

Bunga rampai ini disusun untuk menghadirkan beragam perspektif dan praktik baik terkait penerapan pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga. Pembahasan mencakup prinsip-prinsip dasar, strategi implementasi, serta tantangan yang sering ditemui oleh tenaga kesehatan, seperti keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, perbedaan budaya, variasi literasi kesehatan, hingga dinamika emosional keluarga saat menghadapi situasi sakit. Melalui penyajian yang aplikatif, Buku Bunga Rampai ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan bersama, edukasi kesehatan, serta koordinasi interprofesional yang berpusat pada pasien dan keluarga.

Buku Bunga Rampai ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, perawat, bidan, dokter, tenaga gizi, farmasis, serta seluruh tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan. Selain itu, bunga rampai ini juga dapat menjadi referensi bagi pendidik, pembimbing klinik, dan pengelola layanan kesehatan dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan pengalaman pasien. Harapannya, pembaca memperoleh gambaran yang lebih utuh bahwa pelayanan

berbasis pasien dan keluarga bukan sekadar konsep, tetapi sebuah komitmen profesional yang perlu diwujudkan dalam sikap, tindakan, dan sistem pelayanan.

Akhir kata, semoga “Bunga Rampai Pelayanan Kesehatan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan” dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta menjadi penguat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, berkeadilan, dan manusiawi.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA	1
apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Definisi dan Prinsip Dasar Pelayanan Berbasis Pasien dan Keluarga	2
C. Peran Pasien dan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan.....	2
D. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Berbasis Pasien.....	3
E. Implementasi Pelayanan Berbasis Pasien dalam Sistem Kesehatan	4
F. Tantangan dan Peluang	4
G. Kesimpulan	5
H. Daftar Pustaka	5
I. Glosarium.....	6

CHAPTER 2 PENTINGNYA KETERLIBATAN PASIEN DAN KELUARGA DALAM PELAYANAN KESEHATAN.....	9
M. Noor Ifansyah, S.Kep., Ns., M.Kep.....	9
A. Pendahuluan / Prolog.....	9
B. Konsep Dasar Pelayanan Berpusat pada Pasien dan Keluarga.....	10
C. Manfaat Strategis Keterlibatan Pasien dan Keluarga.....	11
D. Strategi Implementasi bagi Tenaga Kesehatan.....	11
E. Hambatan dalam Keterlibatan Pasien	12
F. Strategi Praktis Peningkatan Keterlibatan Pasien.....	13
G. Strategi Komunikasi Interaktif: Metode Teach-Back sebagai Standar Emas.....	14
H. Akselerasi Keterlibatan melalui Teknologi: Peran mHealth dan Solusi Digital	15
I. Tantangan Etika dan Legal: Privasi vs Keterlibatan Keluarga	16
J. Peran Multidisiplin dalam Pemberdayaan Pasien	16
K. Instrumen Evaluasi Keterlibatan Pasien dan Keluarga.....	19
L. Studi Kasus: Transformasi Pelayanan pada Pasien Penyakit Kronis.....	19

M. Simpulan.....	20
N. Referensi.....	21
O. Glosarium.....	21
 CHAPTER 3 ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA (PATIENT AND FAMILY CENTERED CARE)	23
Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.....	23
A. Pendahuluan / Prolog.....	23
B. Tujuan dan Manfaat Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga.....	25
C. Prinsip Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga.....	27
D. Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga	29
E. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga.....	32
F. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga.....	33
G. Simpulan.....	34
H. Referensi.....	35
I. Glosarium.....	36
 CHAPTER 4 PENDEKATAN GIZI BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA	39
Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes.	39
A. Pendahuluan / Prolog.....	39
B. Konsep dan Prinsip Pendekatan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga	41
C. Dasar Teoretis dan <i>Evidence-Based Practice</i>	42
D. Pendekatan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga pada Berbagai Siklus Kehidupan.....	43
E. Implementasi Pelayanan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan.....	45
F. Tantangan, Inovasi, dan Masa Depan Pelayanan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga.....	49
G. Simpulan.....	49
H. Referensi.....	50
I. Glosarium.....	52

CHAPTER 5 PERAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA	53
Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.....	53
A. Pendahuluan / Prolog.....	53
B. Konsep Tenaga Kesehatan Masyarakat.....	54
C. Konsep Pemberdayaan Keluarga Dalam Kesehatan Masyarakat	56
D. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Keluarga	58
E. Strategi Pemberdayaan Keluarga Oleh Tenaga Kesehatan Masyarakat	61
F. Strategi Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat	64
G. Tantangan Dan Solusi Tenaga Kesehatan Dalam Pemberdayaan Keluarga.....	66
H. Kesimpulan	70
I. Referensi.....	71
J. Glosarium.....	77
 CHAPTER 6 KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA TENAGA KESEHATAN, PASIEN DAN KELUARGA	 79
Nur Aini fatimah, S.Kom., M.Kes.....	79
A. Pendahuluan / Prolog.....	79
B. Tujuan dari Komunikasi Efektif.....	81
C. Unsur-unsur komunikasi efektif.....	82
D. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Komunikasi Efektif	82
E. Karakteristik dari Komunikasi Efektif.....	83
F. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mengupayakan Komunikasi efektif dalam tim kesehatan:.....	84
G. Komunikasi dengan Keluarga Pasien.....	84
H. Tehnik-tehnik Komunikasi Efekteif Tenaga Kesehatan kepada Pasien dan Keluarga Pasien.....	85
I. Prinsip-prinsip Komunikasi Efektif	86
J. Contoh Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan, Pasien dan Keluarga Pasien.....	89
K. Simpulan.....	90
L. Referensi.....	91
M.Glosarium.....	92
 PROFIL PENULIS	 95

CHAPTER 1

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA

apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kesehatan modern mengalami pergeseran paradigma dari model paternalistik menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan klinis (Institute of Medicine [IOM], 2001). Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan hak pasien, transparansi layanan, serta pentingnya kualitas hidup dalam hasil pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga (Patient and Family-Centered Care/PFCC) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sistem kesehatan yang lebih manusiawi, holistik, dan berorientasi pada nilai (value-based care). Konsep ini menekankan penghormatan terhadap preferensi, kebutuhan, serta nilai-nilai pasien dan keluarganya dalam setiap tahapan pelayanan (Epstein & Street, 2011). Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien, keselamatan, serta efisiensi pelayanan kesehatan (World Health Organization [WHO], 2016).

Paradigma pelayanan kesehatan kini bertransformasi dari pendekatan biomedical semata menjadi lebih partisipatif, dimana pasien dan keluarga menjadi mitra aktif dalam keputusan klinis dan proses perawatan. Ini erat terkait dengan konsep *patient- and family-centered care* (PFCC) yang bertujuan meningkatkan kepuasan, kualitas layanan, dan outcome klinis. PFCC menempatkan martabat, penghormatan terhadap preferensi pasien, partisipasi keluarga, dan kolaborasi sebagai prinsip inti dalam pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, pelayanan kefarmasian dan pelayanan rumah sakit menghadapi tuntutan untuk fokus tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada keterlibatan pasien, keluarga, dan komunikasi yang efektif. Misalnya, studi di sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya *pharmaceutical care* yang berorientasi pasien dalam meningkatkan hasil terapi dan kepatuhan pasien, meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya.

B. Definisi dan Prinsip Dasar Pelayanan Berbasis Pasien dan Keluarga

Pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga didefinisikan sebagai pendekatan sistematis dalam perencanaan, pemberian, dan evaluasi pelayanan kesehatan yang melibatkan pasien serta keluarga sebagai mitra sejajar dalam tim pelayanan kesehatan (Institute for Patient- and Family-Centered Care [IPFCC], 2017). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada aspek psikososial, budaya, dan spiritual pasien.

Terdapat empat prinsip utama dalam PFCC, yaitu: (1) penghormatan dan martabat (*dignity and respect*), (2) berbagi informasi (*information sharing*), (3) partisipasi (*participation*), dan (4) kolaborasi (*collaboration*) (IPFCC, 2017). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun hubungan terapeutik yang saling percaya antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga.

Penghormatan terhadap nilai dan preferensi pasien merupakan inti dari pelayanan berbasis pasien. Tenaga kesehatan perlu memahami latar belakang budaya, keyakinan, serta kondisi sosial pasien agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individual (WHO, 2016). Hal ini juga berkaitan dengan konsep *autonomy* dalam bioetika, di mana pasien memiliki hak untuk menentukan pilihan atas pelayanan yang diterimanya (Beauchamp & Childress, 2019).

PFCC didefinisikan sebagai pendekatan pelayanan kesehatan yang merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi perawatan bersama pasien dan keluarga sebagai mitra sejajar tenaga kesehatan. Prinsip-prinsipnya meliputi penghormatan, berbagi informasi, partisipasi aktif pasien/keluarga, serta kolaborasi tim kesehatan dengan pasien dan keluarga dalam setiap aspek perawatan.

Pendekatan ini bukan hanya teori, tetapi didukung bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan pasien/keluarga dapat meningkatkan pemahaman, kepatuhan terapi, serta menurunkan kesalahan medis. Misalnya, beberapa RCT dan review terbaru menghubungkan PFCC dengan penurunan kecemasan pasien dan peningkatan outcome klinis pada unit intensif dan setting rawat inap lainnya.

C. Peran Pasien dan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan

Dalam model tradisional, keputusan klinis sepenuhnya berada di tangan tenaga kesehatan. Namun, dalam pendekatan berbasis pasien dan keluarga, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui mekanisme *shared decision-making* (SDM) (Elwyn et al., 2012). SDM memungkinkan pasien memahami pilihan terapi, risiko, manfaat, dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Keterlibatan keluarga menjadi penting terutama pada pasien dengan kondisi kronis, anak-anak, lansia, atau pasien dengan keterbatasan kognitif. Keluarga sering kali menjadi *caregiver* utama yang berperan dalam pemantauan terapi dan

kepatuhan pengobatan (Clay & Parsh, 2016). Oleh karena itu, edukasi dan komunikasi yang efektif kepada keluarga menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pasien dan keluarga dapat menurunkan angka kesalahan medis serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi (IOM, 2001). Dengan demikian, PFCC tidak hanya berdampak pada aspek psikososial, tetapi juga pada outcome klinis.

PFCC memperluas model *shared decision-making* di luar hanya pasien menjadi keluarga, terutama pada pasien kronis, lansia, dan anak. Bukti sistematis menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pasien dan keluarga mampu mengurangi readmissions, serta meningkatkan pemahaman pasien terhadap rencana perawatan dan pemulihan.

Pendekatan ini juga mengubah peran apoteker dan tenaga farmasi menjadi bagian dari tim kolaboratif, bukan hanya sebagai penyedia obat tetapi konsultan kesehatan yang berkomitmen pada keamanan obat, edukasi pasien, dan pengelolaan penggunaan obat secara rasional.

D. Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Berbasis Pasien

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam implementasi pelayanan berbasis pasien dan keluarga. Komunikasi yang efektif mencakup kemampuan mendengar secara aktif, empati, serta penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami (Epstein & Street, 2011). Hambatan komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi, ketidakpuasan, hingga kesalahan medis.

Penggunaan bahasa yang sederhana, media edukasi visual, serta pendekatan cultural competence penting dalam meningkatkan pemahaman pasien (WHO, 2016). Tenaga kesehatan perlu menyesuaikan cara komunikasi dengan tingkat literasi kesehatan pasien untuk memastikan informasi benar-benar dipahami.

Model komunikasi terapeutik juga menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang saling menghargai. Hubungan ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan (trust) yang menjadi fondasi dalam pelayanan kesehatan berbasis pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

Komunikasi efektif adalah kunci dalam PFCC karena memastikan transfer informasi yang jelas antara provider, pasien, dan keluarga. Hambatan seperti literasi kesehatan yang rendah, perbedaan budaya, atau sistem birokrasi dapat menghambat kualitas komunikasi dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan.

Model komunikasi terapeutik harus melibatkan penyampaian informasi oleh apoteker kepada pasien/keluarga soal terapi obat, kemungkinan efek samping, dan

pengaturan jadwal obat untuk mengoptimalkan hasil terapi. Pendekatan ini juga meningkatkan rasa aman dan kepuasan pasien.

E. Implementasi Pelayanan Berbasis Pasien dalam Sistem Kesehatan

Implementasi PFCC memerlukan perubahan budaya organisasi, kebijakan institusi, serta pelatihan tenaga kesehatan. Sistem kesehatan perlu mengintegrasikan pendekatan ini dalam standar operasional prosedur, sistem akreditasi, dan evaluasi mutu layanan (WHO, 2016).

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat menerapkan PFCC melalui pembentukan komite pasien dan keluarga, survei kepuasan berbasis pengalaman pasien (*patient experience*), serta pelibatan pasien dalam perencanaan layanan (IPFCC, 2017). Pendekatan ini mendukung sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Di era pelayanan kesehatan berbasis nilai (*value-based healthcare*), PFCC juga berkontribusi dalam efisiensi biaya melalui peningkatan kepatuhan terapi dan penurunan *readmission rate* (Epstein & Street, 2011). Oleh karena itu, pendekatan ini relevan dalam reformasi sistem kesehatan global.

Di rumah sakit Indonesia, pelayanan kefarmasian dan PFCC berkontribusi pada kepuasan pasien rawat jalan dan rawat inap melalui:

1. Pelayanan *pharmaceutical care* terintegrasi dengan tim klinis
 2. Edukasi pasien dan keluarga mengenai penggunaan obat
 3. Evaluasi dan umpan balik pada intervensi terapi obat
- Penelitian lokal menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian berkaitan erat dengan kualitas komunikasi, responsivitas staf, dan edukasi obat yang diberikan.

Puskesmas sebagai layanan primer juga dapat menerapkan model kefarmasian klinik untuk meningkatkan rasionalitas penggunaan obat dan keselamatan pasien, serta memperluas peran apoteker dalam *patient and family engagement*.

F. Tantangan dan Peluang

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PFCC menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu konsultasi, beban kerja tenaga kesehatan, serta kurangnya pelatihan komunikasi (Clay & Parsh, 2016). Selain itu, perbedaan budaya dan tingkat pendidikan pasien juga dapat memengaruhi efektivitas pendekatan ini.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital seperti *telemedicine* dan rekam medis elektronik membuka peluang peningkatan keterlibatan pasien (WHO,

2016). Digital health memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan transparan, sehingga mendukung prinsip partisipasi aktif pasien.

Tantangan utama implementasi PFCC dan pelayanan kefarmasian di Indonesia antara lain:

1. Beban kerja staf kesehatan
2. Keterbatasan waktu per konsultasi
3. Variasi tingkat literasi pasien
4. Integrasi kefarmasian klinik dalam tim multidisiplin

Namun, peluang ditunjang oleh dukungan kebijakan kesehatan dan inovasi digital seperti *telepharmacy* dan rekam medis elektronik yang dapat membantu kolaborasi tim dan komunikasi pasien

G. Kesimpulan

Pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga merupakan paradigma modern yang menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam proses pelayanan. Prinsip penghormatan, partisipasi, kolaborasi, dan komunikasi efektif menjadi fondasi utama pendekatan ini. Implementasi yang optimal memerlukan dukungan kebijakan, budaya organisasi, serta kompetensi tenaga kesehatan. Dengan penerapan yang konsisten, PFCC berpotensi meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien, serta outcome klinis secara berkelanjutan.

Patient and Family-Centered Care memperkuat peran pasien/keluarga sebagai mitra aktif pelayanan kesehatan dan mempengaruhi desain layanan kefarmasian modern. Kontribusi apoteker sebagai bagian dari tim klinik mampu memaksimalkan outcome pasien. Integrasi PFCC dalam sistem layanan kesehatan Indonesia ditopang oleh bukti internasional dan lokal bahwa keterlibatan pasien meningkatkan kualitas, keselamatan, serta kepuasan pasien secara signifikan.

H. Daftar Pustaka

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Clay, A. M., & Parsh, B. (2016). Patient- and family-centered care: It's not just for pediatrics anymore. *AMA Journal of Ethics*, 18(1), 40–44.
- Elwyn, G., Frosch, D., & Rollnick, S. (2012). Dual equipoise shared decision making: definitions for decision and behaviour support interventions. *Implementation Science*, 7(1), 1–8.

Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). *The values and value of patient-centered care*. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103.

Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2017). *Advancing the practice of patient- and family-centered care in hospitals*. IPFCC.

Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academy Press.

World Health Organization. (2016). *Framework on integrated, people-centred health services*. WHO Press.

I. Glosarium

Adverse Drug Reaction (ADR)

Reaksi obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis normal penggunaan obat untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi.

Autonomy (Otonomi Pasien)

Hak pasien untuk membuat keputusan secara bebas dan sadar terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya berdasarkan informasi yang memadai.

Bedside Rounds (Visite Interprofesi)

Kegiatan kunjungan klinis di samping tempat tidur pasien yang melibatkan tim multidisiplin serta pasien dan keluarga dalam diskusi rencana perawatan.

Caregiver

Individu (anggota keluarga atau orang lain) yang memberikan dukungan fisik, emosional, dan/atau sosial kepada pasien selama proses perawatan.

Clinical Pharmacy Services (Pelayanan Kefarmasian Klinik)

Layanan profesional apoteker yang berfokus pada optimalisasi terapi obat, pemantauan efektivitas dan keamanan terapi, serta peningkatan outcome pasien.

Collaborative Practice (Praktik Kolaboratif)

Model pelayanan kesehatan yang melibatkan kerja sama antara tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat, dll.) dengan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan klinis.

Cultural Competence (Kompetensi Budaya)

Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan menghormati latar belakang budaya, nilai, dan keyakinan pasien dalam proses pelayanan.

Family-Centered Care (FCC)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan pasien.

Health Literacy (Literasi Kesehatan)

Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan guna membuat keputusan yang tepat.

Informed Consent

Persetujuan pasien setelah menerima penjelasan lengkap mengenai diagnosis, pilihan terapi, manfaat, risiko, dan alternatif tindakan medis.

Interprofessional Collaboration (Kolaborasi Interprofesi)

Kerja sama antara berbagai profesi kesehatan dalam merencanakan dan memberikan pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien.

Medication Error (Kesalahan Pengobatan)

Kesalahan yang terjadi dalam proses peresepan, penyiapan, distribusi, atau penggunaan obat yang dapat membahayakan pasien.

Medication Therapy Management (MTM)

Pendekatan sistematis oleh apoteker untuk mengoptimalkan penggunaan obat melalui evaluasi terapi, identifikasi masalah terkait obat, dan tindak lanjut.

Patient-Centered Care (PCC)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai individu pasien.

Patient Engagement (Keterlibatan Pasien)

Partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan kesehatannya, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terapi.

Patient Experience

Persepsi pasien terhadap kualitas interaksi dan pelayanan yang diterima selama proses perawatan.

Patient Safety (Keselamatan Pasien)

Upaya sistematis untuk mencegah kesalahan dan cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan.

Pharmaceutical Care

Praktik profesional di mana apoteker bertanggung jawab atas hasil terapi obat pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Readmission Rate

Angka pasien yang kembali dirawat dalam periode tertentu setelah keluar dari rumah sakit, sering digunakan sebagai indikator mutu pelayanan.

Shared Decision-Making (SDM)

Proses kolaboratif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam memilih intervensi berdasarkan bukti ilmiah serta preferensi pasien.

Telepharmacy

Pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi untuk konsultasi, edukasi, dan pemantauan terapi obat.

Value-Based Healthcare (VBHC)

Model pelayanan kesehatan yang menekankan pencapaian outcome terbaik bagi pasien dengan efisiensi biaya.

CHAPTER 2

PENTINGNYA KETERLIBATAN PASIEN DAN KELUARGA DALAM PELAYANAN KESEHATAN

M. Noor Ifansyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Transformasi pelayanan kesehatan modern telah bergeser dari model paternalistik, di mana tenaga kesehatan menjadi satu-satunya pengambil keputusan, menuju model *Patient and Family-Centered Care* (PFCC). Pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga menempatkan pasien sebagai mitra sejajar dalam tim kesehatan (Johnson & Abraham, 2020). Keterlibatan aktif pasien dan keluarga bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen inti dalam meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) dan kualitas asuhan.

Penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien terlibat dalam perawatan mereka, terjadi penurunan signifikan pada angka kejadian yang tidak diharapkan (KTD) dan peningkatan kepatuhan pengobatan (WHO, 2023). Hal ini dikarenakan pasien dan keluarga adalah orang yang paling memahami kondisi harian, riwayat kesehatan, dan nilai-nilai pribadi yang dianut. Keterlibatan ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis, hingga memberikan umpan balik terhadap layanan yang diterima. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan ini sering kali terhambat oleh masalah literasi kesehatan, kendala komunikasi, dan budaya kerja tenaga kesehatan yang masih kaku (Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2021).

Pergeseran paradigma dalam pelayanan kesehatan modern telah menempatkan pasien dan keluarga bukan lagi sebagai objek pasif dari intervensi medis, melainkan sebagai mitra aktif. Konsep *Patient and Family-Centered Care* (PFCC) menekankan bahwa kesehatan adalah hasil kolaborasi antara pemberi layanan, pasien, dan sistem pendukung sosial mereka. Pentingnya keterlibatan ini didasari oleh pemahaman bahwa pasien adalah "ahli" atas tubuh dan pengalaman hidup mereka sendiri, sementara tenaga kesehatan adalah ahli dalam sains medis.

Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya jurang komunikasi. Hambatan seperti rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan tentang proses medis, hingga faktor sosial ekonomi sering kali menghalangi pasien untuk terlibat secara bermakna. Masalah kesehatan sering kali menjadi kompleks ketika terdapat hambatan bahasa dan perbedaan budaya antara pasien dan petugas kesehatan.

Oleh karena itu, keterlibatan pasien bukan sekadar masalah etika, melainkan strategi klinis untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas.

Menurut World Health Organization (WHO) dalam *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030*, pelibatan pasien dapat mengurangi beban bahaya akibat asuhan yang tidak aman hingga 15%. Hal ini dikarenakan pasien dan keluarga adalah "saksi bisu" yang paling konsisten dalam seluruh perjalanan asuhan mereka. Mereka memiliki data unik mengenai riwayat pengobatan, reaksi alergi, dan preferensi nilai yang tidak selalu tercatat dalam rekam medis elektronik. Bab ini akan membedah secara mendalam strategi praktis, tantangan etis, bagaimana tenaga kesehatan dapat mengintegrasikan pasien dan keluarga dalam setiap lini pelayanan, mulai dari komunikasi di samping tempat tidur hingga pemanfaatan teknologi digital.

B. Konsep Dasar Pelayanan Berpusat pada Pasien dan Keluarga

Pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga bertumpu pada empat pilar utama yang harus diintegrasikan ke dalam praktik setiap tenaga kesehatan:

1. Martabat dan Penghormatan

Tenaga kesehatan harus mendengarkan dan menghormati pilihan serta nilai-nilai yang dianut pasien dan keluarga. Pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan latar belakang budaya pasien harus menjadi dasar dalam perencanaan dan pemberian asuhan. Seringkali, praktik tradisional yang diyakini secara turun-temurun berlawanan dengan informasi medis, yang jika tidak dikelola dengan rasa hormat, akan membingungkan pasien.

2. Berbagi Informasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci. Tenaga kesehatan harus mengomunikasikan dan berbagi informasi yang lengkap serta akurat kepada pasien dan keluarga dengan cara yang memberdayakan. Kurangnya informasi dari petugas kesehatan dan minimnya upaya promotif-preventif sering kali menjadi akar masalah ketidakpatuhan pasien.

3. Partisipasi

Pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan asuhan sesuai dengan tingkat pilihan mereka. Hal ini mencakup diskusi mengenai rencana reproduksi atau rencana pengobatan jangka panjang.

4. Kolaborasi

Keluarga dan pasien harus dilibatkan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta program pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan bersifat *user-friendly* atau ramah bagi pengguna.

Kapasitas pasien untuk terlibat sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pendukung emosional, pemberi asuhan di rumah, sekaligus advokat bagi pasien saat mereka dalam kondisi rentan (Dudley et al., 2022). Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memandang keluarga bukan sebagai "pengunjung", melainkan sebagai bagian dari sistem perawatan yang integral.

Tenaga kesehatan harus menghormati pilihan dan latar belakang budaya pasien. Berbagi informasi berarti memastikan pasien mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu agar dapat membuat keputusan yang berbasis informasi (*informed decision*).

C. Manfaat Strategis Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Keterlibatan pasien dan keluarga membawa dampak positif yang luas, antara lain:

- 1. Peningkatan Keselamatan Pasien:** Pasien yang teredukasi dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan medis, seperti kekeliruan pemberian obat atau kesalahan identifikasi (WHO, 2023).
- 2. Hasil Klinis yang Lebih Baik:** Partisipasi dalam *Shared Decision Making* (SDM) terbukti meningkatkan kepuasan pasien dan mempercepat proses pemulihan karena rencana perawatan disesuaikan dengan gaya hidup pasien.
- 3. Efisiensi Biaya:** Pasien yang terlibat cenderung memiliki angka rawat inap ulang (*readmission rate*) yang lebih rendah karena mereka memahami cara mengelola kondisi kesehatan secara mandiri di rumah (National Academy of Medicine, 2021).

D. Strategi Implementasi bagi Tenaga Kesehatan

Untuk mewujudkan keterlibatan yang efektif, tenaga kesehatan dapat menerapkan beberapa strategi praktis:

- 1. Shared Decision Making (SDM):** Proses diskusi antara tenaga kesehatan dan pasien untuk memilih pemeriksaan, perawatan, atau dukungan berdasarkan bukti klinis dan nilai-nilai pasien.
- 2. Health Literacy Alignment:** Menggunakan teknik *teach-back* untuk memastikan pasien memahami instruksi medis. Tenaga kesehatan meminta pasien menjelaskan kembali informasi yang telah diberikan dengan bahasa mereka sendiri.
- 3. Bedside Handover:** Melibatkan pasien dan keluarga dalam proses timbang terima perawat atau dokter di samping tempat tidur, sehingga pasien dapat mendengar rencana perawatan dan memberikan klarifikasi langsung.

E. Hambatan dalam Keterlibatan Pasien

Meskipun manfaatnya jelas, beberapa tantangan masih membayangi:

1. Hambatan Komunikasi: Penggunaan istilah medis yang terlalu rumit sering kali membuat pasien merasa terintimidasi dan enggan bertanya.
2. Beban Kerja Tenaga Kesehatan: Rasio pasien yang tinggi sering kali membuat tenaga kesehatan merasa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan diskusi mendalam dengan keluarga.
3. Stigma dan Budaya: Di beberapa budaya, mempertanyakan keputusan dokter dianggap tidak sopan, sehingga pasien cenderung pasif (Higgins et al., 2020). Terutama pada populasi rentan seperti pengungsi atau kelompok minoritas, pengalaman terhadap stigma dapat memicu rasa tidak percaya pada petugas kesehatan. Masalah kesehatan reproduksi atau penyakit menular seringkali tertutup oleh stigma (Meo & Nahak, 2020). Pendekatan yang kongruen secara budaya—melibatkan tokoh agama atau tetua adat—menjadi strategi kunci dalam pelibatan keluarga. Hal ini diperburuk jika petugas kesehatan tidak memiliki pelatihan untuk memberikan pelayanan yang kongruen secara budaya.
4. Faktor Sosial Ekonomi: Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah terbukti berpengaruh terhadap terjadinya masalah komunikasi dalam kesehatan. Kepercayaan seperti "banyak anak banyak rezeki" atau anggapan bahwa masalah kesehatan tertentu hanya urusan satu gender dapat menghambat diskusi terbuka antara pasien, keluarga, dan dokter.
5. Struktur Kekuasaan dalam Keluarga: Dalam budaya patriarkhi, pusat kekuasaan sering ada pada suami atau mertua, sehingga pasien (khususnya perempuan) membutuhkan persetujuan pihak lain untuk mengakses layanan atau menggunakan kontrasepsi.
6. Bias Otoritas: Di banyak budaya, tenaga kesehatan dianggap "dewa" yang tidak boleh dibantah. Hal ini membuat pasien merasa enggan untuk bertanya atau melaporkan kesalahan medis yang mereka lihat.
7. Beban Kerja dan Rasio Staf: Kurangnya jumlah staf membuat waktu untuk melakukan *Shared Decision Making* menjadi sangat terbatas. Keterlibatan pasien sering kali dianggap "memakan waktu".
8. Kurangnya Pelatihan: Banyak tenaga kesehatan memiliki kompetensi klinis yang luar biasa, namun memiliki keterampilan komunikasi terapeutik yang minim.
9. Budaya "Pasrah": Banyak pasien merasa tidak sopan jika bertanya atau mendebat dokter. Tenaga kesehatan harus proaktif menciptakan ruang aman bagi pasien untuk bersuara.
10. Literasi Digital: Meskipun penggunaan ponsel tinggi, literasi digital kesehatan masih rendah. Tenaga kesehatan perlu membimbing keluarga dalam

menggunakan aplikasi kesehatan agar informasi yang didapat valid dan tidak terpengaruh hoaks.

Untuk mengatasi ini, diperlukan reposisi kurikulum pendidikan tenaga kesehatan yang lebih menekankan pada aspek humaniora dan keterampilan komunikasi, selain dari aspek teknis medis.

F. Strategi Praktis Peningkatan Keterlibatan Pasien

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang Strategis

Peran KIE sangat strategis dalam memberdayakan pasien. KIE tidak boleh hanya bersifat searah, melainkan harus interaktif, di mana terdapat keseimbangan antara suara pasien dan tenaga kesehatan. Penggunaan berbagai media edukasi diperlukan agar pesan dapat diterima oleh berbagai lapisan sasaran.

2. Pemanfaatan Teknologi (mHealth)

Digitalisasi kesehatan memberikan peluang besar untuk melibatkan pasien secara berkelanjutan. Intervensi berbasis telepon atau pesan singkat (SMS) terbukti efektif dalam:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan penggunaan layanan kesehatan.
- b. Memfasilitasi komunikasi pasca-prosedur medis.
- c. Mendorong perubahan perilaku sehat, seperti pemberian ASI eksklusif dan kepatuhan pengobatan.
- d. Mengatasi hambatan geografis bagi pasien yang sulit mengakses klinik secara fisik.

3. Pendekatan Dukungan Teman Sebaya (*Peer Group*)

Model pelayanan yang melibatkan kader kesehatan atau kelompok dukungan sebaya dapat menawarkan pilihan yang memberdayakan bagi pasien muda atau mereka yang merasa terisolasi. Merasa didukung dan didengarkan oleh sesama yang memiliki pengalaman hidup serupa dapat meningkatkan kontrol aktif pasien atas kesehatan mereka.

4. Peran Keluarga sebagai Advokat dan Pendukung

Keluarga memiliki peran ganda: sebagai pendukung emosional dan sebagai sumber informasi bagi tenaga kesehatan. Keterlibatan keluarga muda melalui kunjungan rumah dan pendampingan dapat mencegah risiko kesehatan berulang. Namun, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa keterlibatan keluarga tetap menghormati otonomi pasien dan tidak menjadi tekanan tambahan, terutama dalam pengambilan keputusan reproduksi.

G. Strategi Komunikasi Interaktif: Metode Teach-Back sebagai Standar Emas

Salah satu hambatan terbesar dalam keterlibatan pasien adalah rendahnya literasi kesehatan (*health literacy*). Banyak pasien mengangguk saat diberikan instruksi medis, namun sebenarnya tidak memahami apa yang harus mereka lakukan di rumah. Di sinilah metode *Teach-Back* menjadi sangat vital.

1. Definisi dan Mekanisme Teach-Back

Teach-back bukanlah tes atau ujian bagi pasien, melainkan tes bagi tenaga kesehatan dalam menjelaskan informasi. Metode ini mengharuskan tenaga kesehatan meminta pasien untuk menjelaskan kembali informasi yang baru saja diberikan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jika pasien tidak dapat menjelaskan dengan benar, tenaga kesehatan harus mengulang penjelasan dengan cara yang berbeda hingga pasien paham (Tamura-Lis, 2013).

2. Langkah Praktis Implementasi Teach-Back

Tenaga kesehatan dapat mengikuti alur berikut untuk memastikan efektivitas komunikasi:

- Gunakan Bahasa Sederhana: Hindari jargon medis seperti "hipertensi" (gunakan "darah tinggi") atau "ambulasi" (gunakan "belajar berjalan kembali").
- Pendekatan "Chunk and Check": Berikan informasi dalam potongan kecil (misal: cara minum obat saja), lalu lakukan pengecekan sebelum pindah ke topik berikutnya (misal: pantangan makanan).
- Pertanyaan Terbuka: Alih-alih bertanya "Apakah Anda paham?", gunakan kalimat "Saya ingin memastikan saya menjelaskan ini dengan jelas. Bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana rencana Anda meminum obat ini saat sampai di rumah nanti?"
- Gunakan Alat Bantu Visual: Sertakan gambar atau brosur yang mendukung penjelasan verbal.

3. Dampak Klinis Teach-Back

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *teach-back* yang konsisten menurunkan risiko rawat inap ulang hingga 20% pada pasien gagal jantung karena mereka lebih patuh terhadap manajemen cairan dan pengobatan (Dudley et al., 2022).

Tabel 2.1 Panduan Komunikasi *Teach-Back*

No.	Topik Edukasi	Contoh Kalimat Tenaga Kesehatan	Target Pemahaman Pasien/Keluarga
1.	Penggunaan Obat	"Saya ingin memastikan penjelasan saya jelas. Bisa tolong tunjukkan obat mana"	Pasien tahu waktu, dosis, dan cara simpan obat.

		yang diminum sebelum makan?"	
2.	Perawatan Luka	"Jika nanti di rumah Anda melihat perban ini basah, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan?"	Keluarga tahu tanda-tanda infeksi dan prosedur kebersihan.
3.	Diet Khusus	"Bisa ceritakan kembali pada saya, makanan apa saja yang perlu dikurangi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil?"	Pasien mampu memilih menu makanan yang aman secara mandiri.

H. Akselerasi Keterlibatan melalui Teknologi: Peran mHealth dan Solusi Digital

Pemanfaatan aplikasi seluler (*mHealth*) kini menjadi jembatan utama antara rumah sakit dan rumah pasien. Di era digital, keterlibatan pasien tidak lagi terbatas pada dinding rumah sakit. *Mobile Health* (mHealth) telah membuka ruang bagi keluarga untuk menjadi mitra aktif dalam pemantauan kondisi pasien secara *real-time*.

1. Pemantauan Jarak Jauh dan Kepatuhan

Aplikasi seluler kini memungkinkan keluarga untuk memantau tanda-tanda vital pasien kronis (seperti diabetes atau hipertensi) di rumah. Data ini dapat disinkronkan langsung ke sistem rumah sakit. Selain itu, sistem pengingat otomatis (SMS atau notifikasi aplikasi) telah terbukti secara signifikan meningkatkan angka kepatuhan pengobatan dan kehadiran kontrol rutin (Harrington et al., 2019).

2. Keluarga sebagai "Co-Manager" dalam mHealth

Bagi pasien lanjut usia atau anak-anak, keluarga berperan sebagai pengelola utama kesehatan. Teknologi mHealth memungkinkan pembagian akses informasi medis (*shared access*) kepada anggota keluarga yang ditunjuk. Hal ini mengurangi asimetri informasi antara dokter dan keluarga besar, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam pengambilan keputusan medis di budaya kolektif seperti Indonesia.

3. Edukasi Berkelanjutan via Platform Digital

Rumah sakit yang menyediakan portal edukasi interaktif seperti video instruksi perawatan luka atau rehabilitasi mandiri memberikan rasa percaya diri kepada keluarga untuk memberikan asuhan di rumah. Hal ini mengurangi kecemasan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-rawat.

Implementasi Konkrit mHealth:

- a. Sistem Pengingat (SMS/Notifikasi): Terbukti meningkatkan kehadiran kontrol rutin hingga 40% (Harrington et al., 2019).
- b. Tele-Monitoring: Keluarga dapat melaporkan tanda vital (suhu, tensi) melalui aplikasi, yang secara otomatis memberikan peringatan kepada perawat jika data berada di zona bahaya.
- c. Edukasi Video: Mengganti brosur kertas dengan video pendek tentang cara memandikan bayi atau teknik injeksi insulin mandiri yang dapat diakses kapan saja oleh keluarga.

I. Tantangan Etika dan Legal: Privasi vs Keterlibatan Keluarga

Dalam konteks budaya Indonesia yang kolektif, keluarga sering kali memegang peranan dominan dalam pengambilan keputusan. Namun, tenaga kesehatan sering kali terjepit di antara dua kepentingan: privasi pasien dan tuntutan keluarga.

1. Hak Atas Informasi dan Kerahasiaan

Berdasarkan regulasi kesehatan di Indonesia, pasien memiliki hak mutlak atas kerahasiaan medisnya. Tantangan muncul ketika keluarga menuntut untuk mengetahui diagnosis (misalnya pada kasus HIV atau kanker stadium akhir) sementara pasien ingin merahasiakannya. Tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi negosiasi etis untuk menyeimbangkan kebutuhan dukungan keluarga tanpa melanggar hak hukum pasien.

2. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)

Informed consent bukan sekadar penandatanganan formulir, melainkan sebuah proses diskusi. Keterlibatan keluarga dalam proses ini sangat penting sebagai saksi dan pendukung keputusan, terutama jika pasien berada dalam kondisi kritis. Namun, secara hukum, urutan prioritas wali harus tetap dipatuhi untuk menghindari sengketa medis di kemudian hari.

J. Peran Multidisiplin dalam Pemberdayaan Pasien

Pelayanan kesehatan berbasis pasien dan keluarga (PKBPK) tidak dapat dijalankan secara terfragmentasi. Keberhasilan pelibatan pasien sangat bergantung pada sejauh mana tim interprofesional dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi bekerja sama dalam satu visi. Kolaborasi interprofesional (IPC) memastikan bahwa informasi yang diterima pasien konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan. Keterlibatan pasien bukan hanya tugas satu profesi, melainkan tanggung jawab kolaboratif:

1. Dokter: Fasilitator *Shared Decision Making* (SDM)

Berperan dalam *Shared Decision Making* (SDM), memberikan pilihan terapi berbasis bukti yang sesuai dengan nilai pasien. Dokter memegang peran sentral sebagai pemberi informasi klinis utama. Dalam model PKBPK, peran dokter bergeser dari pengambil keputusan tunggal menjadi fasilitator dalam *Shared Decision Making* (SDM). SDM adalah proses komunikasi di mana dokter dan pasien berbagi bukti klinis terbaik yang tersedia, dan pasien didorong untuk mempertimbangkan pilihan tersebut dalam konteks nilai-nilai dan preferensi pribadi mereka.

Tantangan utama dokter di Indonesia adalah mengatasi asimetri informasi. Seringkali, dokter terjebak dalam penggunaan jargon medis yang rumit. Untuk melibatkan pasien secara efektif, dokter harus mampu melakukan "penerjemahan klinis". Sebagai contoh, saat menjelaskan risiko operasi, dokter tidak hanya memaparkan angka persentase keberhasilan, tetapi juga mendiskusikan bagaimana operasi tersebut akan berdampak pada kualitas hidup harian pasien dan keterlibatan keluarga dalam perawatan pasca-operasi.

Dokter juga bertanggung jawab atas transparansi diagnosis. Dalam etika medis modern, menyembunyikan diagnosis dari pasien atas permintaan keluarga (sering terjadi pada kasus kanker) kini mulai ditinggalkan. Dokter harus berperan sebagai mediator yang memberikan pengertian kepada keluarga bahwa keterbukaan informasi adalah hak pasien dan merupakan langkah awal untuk membangun kerja sama yang jujur dalam proses pengobatan.

2. Perawat: Advokat dan Jembatan Komunikasi 24 Jam

Sebagai pendamping 24 jam, perawat melakukan Bedside Handover yang melibatkan pasien dalam pergantian shift agar pasien tahu rencana perawatan selanjutnya. Perawat adalah anggota tim kesehatan yang memiliki waktu interaksi paling lama dengan pasien. Oleh karena itu, perawat berperan sebagai "jembatan" utama antara pasien, keluarga, dan anggota tim medis lainnya. Peran perawat dalam PKBPK diwujudkan melalui strategi Bedside Handover (timbang terima di samping tempat tidur).

Berbeda dengan timbang terima tradisional di ruang perawat, Bedside Handover melibatkan pasien dan keluarga dalam diskusi rencana asuhan harian. Perawat memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengoreksi informasi, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan kondisi mereka, dan mengetahui siapa perawat yang akan bertanggung jawab pada shift berikutnya. Hal ini terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kecemasan pasien dan meningkatkan rasa aman.

Selain itu, perawat bertindak sebagai advokat. Jika pasien merasa ragu terhadap suatu tindakan namun sungkan bertanya kepada dokter, perawatlah yang memfasilitasi komunikasi tersebut. Perawat juga melatih keluarga dalam keterampilan asuhan dasar (seperti mobilisasi miring kanan-miring kiri atau perawatan kateter) agar keluarga siap saat pasien pulang ke rumah (*discharge planning*).

3. Apoteker: Penjamin Keamanan Pengobatan (*Medication Safety*)

Melakukan rekonsiliasi obat bersama keluarga untuk mencegah medication error di rumah. Kesalahan pengobatan (medication error) adalah salah satu ancaman keselamatan pasien terbesar. Apoteker memiliki peran krusial dalam melibatkan pasien melalui rekonsiliasi obat dan konseling farmasi yang mendalam. Keterlibatan keluarga sangat penting di sini, terutama bagi pasien lansia yang memiliki daftar obat yang panjang (polifarmasi).

Apoteker melibatkan pasien dengan cara meninjau kembali semua obat yang dibawa dari rumah dan membandingkannya dengan resep baru di rumah sakit. Dalam sesi konseling, apoteker tidak hanya menjelaskan dosis, tetapi juga manajemen efek samping. Misalnya, menjelaskan bahwa obat tertentu dapat menyebabkan pusing, sehingga keluarga perlu mendampingi pasien saat ke kamar mandi.

Strategi "Tas Obat" (Brown Bag Medication Review) adalah salah satu contoh pelibatan aktif di mana pasien diminta membawa semua sediaan obat dan herbal yang mereka konsumsi ke apoteker untuk ditinjau. Hal ini menciptakan dialog terbuka mengenai potensi interaksi obat dan meningkatkan kepatuhan pasien karena mereka memahami alasan di balik setiap terapi yang diberikan.

4. Ahli Gizi: Personalisasi Nutrisi Berbasis Budaya dan Keluarga

Mengedukasi keluarga mengenai pola diet yang aplikatif dengan kearifan lokal (misal: modifikasi menu masakan daerah yang rendah garam). Intervensi gizi sering kali gagal jika tidak mempertimbangkan kebiasaan makan keluarga dan kearifan lokal. Ahli gizi dalam PKBPK berperan melakukan asuhan gizi terstandar yang bersifat partisipatif. Ahli gizi harus berdiskusi dengan anggota keluarga yang bertanggung jawab memasak di rumah untuk menyusun rencana diet yang aplikatif.

Misalnya, pada pasien hipertensi, ahli gizi tidak hanya melarang penggunaan garam, tetapi juga memberikan alternatif bumbu dapur lokal yang aman. Edukasi gizi yang melibatkan keluarga memastikan bahwa transisi diet dari rumah sakit ke rumah berjalan mulus. Tanpa dukungan keluarga, pasien sering kali kembali ke pola makan lama yang memperburuk kondisi klinisnya. Ahli gizi juga berperan dalam memantau asupan pasien di rumah sakit dengan meminta

umpan balik langsung dari keluarga mengenai selera makan dan daya terima makanan rumah sakit.

K. Instrumen Evaluasi Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Untuk mengukur keberhasilan keterlibatan pasien, tenaga kesehatan memerlukan instrumen yang tervalidasi. Berikut adalah daftar instrumen yang dapat digunakan:

1. Kuesioner Kepuasan Pasien (CAHPS - *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems*)

Instrumen standar internasional untuk mengukur pengalaman pasien, termasuk sejauh mana tenaga kesehatan berkomunikasi dengan jelas dan melibatkan mereka dalam keputusan.

2. PPE-15 (Picker Patient Experience Questionnaire)

Kuesioner yang terdiri dari 15 butir pertanyaan untuk mengevaluasi aspek-aspek utama PFCC, seperti keterlibatan keluarga, kenyamanan fisik, dan koordinasi asuhan.

3. Daftar Tilik (Checklist) Observasi Teach-Back

Instrumen bagi supervisor untuk menilai kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan metode *teach-back*.

Indikator: Menggunakan bahasa awam, meminta pasien menjelaskan kembali, melakukan klarifikasi jika pemahaman salah.

4. PAM (Patient Activation Measure)

Instrumen untuk menilai tingkat kesiapan dan kepercayaan diri pasien dalam mengelola kesehatan mereka sendiri.

L. Studi Kasus: Transformasi Pelayanan pada Pasien Penyakit Kronis

Di sebuah Puskesmas di wilayah pedesaan, tingkat ketidakpatuhan pasien diabetes sangat tinggi. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata keluarga tidak dilibatkan karena anggapan bahwa penyakit adalah urusan pribadi pasien.

Intervensi: Puskesmas membentuk "Kelas Keluarga Sehat" di mana setiap pasien harus didampingi satu anggota keluarga. Mereka dilatih menggunakan alat cek gula darah mandiri dan diberikan aplikasi mHealth sederhana.

Hasil: Dalam 6 bulan, angka komplikasi akut menurun drastis karena keluarga mampu melakukan deteksi dini gejala hipoglikemia dan membantu pengaturan pola makan pasien.

M. Simpulan

Pentingnya keterlibatan pasien dan keluarga bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan dalam praktik klinis modern. Melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif seperti teach-back dan pemanfaatan inovasi teknologi mHealth, tenaga kesehatan dapat menciptakan sistem pelayanan yang lebih aman, efisien, dan manusiawi. Sinergi antara keahlian teknis tenaga kesehatan dan pengalaman subjektif pasien adalah kunci utama dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keterlibatan pasien dan keluarga adalah jantung dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Strategi Teach-Back memastikan bahwa informasi tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami. Sementara itu, integrasi mHealth memberikan alat bagi keluarga untuk menjadi mitra asuhan yang aktif dan mandiri. Tenaga kesehatan masa kini dituntut untuk memiliki kompetensi klinis sekaligus kecakapan komunikasi dan teknologi demi mewujudkan keselamatan pasien yang paripurna.

N. Referensi

- Dudley, N., et al. (2022). *Family Involvement in Healthcare: A Systematic Review*. Journal of Patient Experience.
- Harrington, E. K., et al. (2019). *An mHealth SMS Intervention on Postpartum Contraceptive Use Among Women in Kenya: A Randomized Controlled Trial*. American Journal of Public Health, 109(6).
- Higgins, A., et al. (2020). *Barriers and Facilitators to Patient and Family Engagement in Hospital Safety*. Health Expectations Journal, 23(1), 120-131.
- Institute for Patient- and Family-Centered Care (IPFCC). (2021). *Advancing the Practice of Patient- and Family-Centered Care in Hospitals*. Bethesda: IPFCC.
- Johnson, B., & Abraham, M. (2020). *Essential Elements of Patient- and Family-Centered Care*. Academic Press.
- Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). *Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 11(1).
- National Academy of Medicine. (2021). *The Impact of Patient Engagement on Health Outcomes and Costs: A Policy Brief*.
- Tamura-Lis, W. (2013). *Teach-Back for Quality Education and Patient Safety*. Urologic Nursing, 33(6), 267-271.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards Eliminating Avoidable Harm in Health Care*. Geneva: WHO.

O. Glosarium

- Informed Consent:** Persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan medis.
- Interprofessional Collaboration (IPC):** Kerja sama antar berbagai profesi tenaga kesehatan.
- KIE:** Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; strategi penyampaian informasi untuk mengubah perilaku.
- mHealth (Mobile Health):** Penggunaan perangkat nirkabel seluler untuk pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan.
- Paternalistik:** Model di mana penyedia layanan membuat semua keputusan tanpa input dari pasien.
- Patient Activation:** Tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri pasien dalam mengelola kesehatan mereka.

Patient Safety (Keselamatan Pasien): Penghindaran, pencegahan, dan perbaikan hasil buruk atau cedera yang berasal dari proses perawatan kesehatan.

PFCC: *Patient and Family-Centered Care* (Pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga).

Shared Decision Making: Proses di mana dokter dan pasien bekerja bersama untuk membuat keputusan perawatan terbaik.

Teach-Back Method: Teknik komunikasi untuk memastikan pemahaman pasien dengan meminta mereka mengulangi instruksi.

CHAPTER 3

ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA (PATIENT AND FAMILY CENTERED CARE)

Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan hak setiap individu dan menjadi tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat. Dalam praktik keperawatan modern, pendekatan pelayanan tidak lagi berfokus semata pada penyakit, tetapi juga pada pasien sebagai individu yang utuh dengan latar belakang nilai, budaya, dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu model asuhan keperawatan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pasien secara menyeluruh serta melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga adalah pendekatan pemberian asuhan keperawatan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan, serta mengakui bahwa keluarga memiliki peran penting dalam proses perawatan, pengambilan keputusan, dan pemulihan pasien. Pendekatan ini memandang pasien dan keluarga sebagai mitra (*partner*) tenaga kesehatan, bukan sekadar penerima pelayanan. Perawat bekerja sama dengan pasien dan keluarga dengan menghargai nilai, kepercayaan, budaya, serta preferensi mereka. Dalam konsep ini Pasien bukan objek pelayanan, tetapi subjek utama, keluarga diakui perannya sebagai pendukung, pengasuh, dan pengambil keputusan bersama pasien. Perawat, dan tim lain bekerja sama dengan pasien dan keluarga sebagai mitra.

Makna utamanya dari pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan, adalah: 1) menghargai pasien dan keluarga, dimana setiap keputusan pelayanan mempertimbangkan nilai, budaya, keyakinan, dan keinginan pasien serta keluarga. Pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan perawatan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan. 2) Komunikasi terbuka dan transparan, informasi tentang kondisi kesehatan, tindakan dan rencana perawatan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, dan 3) Pelayanan yang holistik, mengandung arti bahwa asuhan keperawatan tidak hanya fokus pada penyakit fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan emosional pasien serta keluarga. Contoh penerapan: Perawat menjelaskan rencana perawatan dan meminta

persetujuan pasien serta keluarga, keluarga dilibatkan dalam perawatan sehari-hari, dan keputusan tindakan mempertimbangkan keinginan pasien dan keluarga.

Pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan keperawatan merupakan pendekatan pelayanan yang menempatkan pasien beserta keluarganya sebagai fokus utama dalam setiap proses asuhan keperawatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai, kepercayaan, budaya, serta preferensi pasien dan keluarga, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai mitra yang bekerja sama dengan pasien dan keluarga melalui komunikasi yang terbuka, pemberian informasi yang jelas dan jujur, serta kolaborasi yang berkesinambungan, sehingga pelayanan yang diberikan bersifat holistik, aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata pasien dan keluarganya.

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga medis (*Patient and Family Centered Care* / PFCC) merupakan pendekatan pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya rasa saling menghormati, komunikasi terbuka, kolaborasi, serta pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Dengan demikian, PFCC diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien. Peran keluarga dalam proses penyembuhan pasien sangatlah signifikan. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai sumber dukungan emosional, sosial, dan psikologis bagi pasien. Keterlibatan keluarga secara aktif dapat membantu pasien dalam memahami kondisinya, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, serta mempercepat proses pemulihan. Oleh sebab itu, perawat perlu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan konsep PFCC secara tepat.

Dalam praktik keperawatan, penerapan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga menuntut perubahan paradigma dari pelayanan yang bersifat paternalistik menuju pelayanan yang bersifat kolaboratif. Perawat dituntut untuk mampu membangun hubungan terapeutik yang baik, menghargai preferensi pasien dan keluarga, serta melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan terkait perawatan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan yang humanis dan holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini disusun untuk membahas konsep, prinsip, serta penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga (*Patient and Family Centered Care* /PFCC). Diharapkan kajian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca, khususnya mahasiswa dan tenaga keperawatan,

mengenai pentingnya asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

B. Tujuan dan Manfaat Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

1. Tujuan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan melibatkan pasien dan keluarga secara aktif sebagai mitra dalam proses perawatan. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek klinis, psikologis, dan sosial sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien

Pendekatan berbasis pasien dan keluarga memungkinkan perawat memberikan asuhan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Keterlibatan pasien dan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko, serta memperkuat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, potensi kejadian tidak diharapkan dapat diminimalkan, sehingga kualitas dan keselamatan pasien meningkat.

b. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga

Dengan menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan, perawat menunjukkan sikap menghargai, empati, dan keterbukaan. Pasien dan keluarga merasa didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan ini berkontribusi pada kepercayaan pasien dan keluarga terhadap tenaga kesehatan serta institusi pelayanan kesehatan.

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi

Keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses perawatan memungkinkan mereka memahami tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan terapi secara lebih baik. Pemahaman yang memadai akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pasien serta keluarga dalam menjalankan terapi yang dianjurkan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap pengobatan, perawatan, dan tindak lanjut dapat meningkat.

d. Mengoptimalkan proses penyembuhan

Asuhan yang melibatkan pasien dan keluarga secara holistik tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial. Dukungan emosional dari keluarga, disertai dengan asuhan keperawatan yang tepat, dapat mempercepat pemulihan pasien. Selain itu, kolaborasi yang baik antara perawat, pasien, dan keluarga membantu

memastikan kontinuitas perawatan baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah.

e. Mengurangi kecemasan dan stres pasien serta keluarga

Informasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam perawatan dapat mengurangi ketidakpastian dan ketakutan terhadap kondisi kesehatan yang dialami. Pasien dan keluarga merasa lebih siap menghadapi proses perawatan, sehingga tingkat kecemasan dan stres dapat ditekan. Lingkungan perawatan yang suportif juga mendukung kesejahteraan psikologis pasien dan keluarga.

f. Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam perawatan

Melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, pasien dan keluarga dibekali pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perawatan secara mandiri. Kemandirian ini penting terutama dalam perawatan lanjutan di rumah, pengelolaan penyakit kronis, serta pencegahan kekambuhan. Dengan meningkatnya kemandirian, pasien dan keluarga dapat mempertahankan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Manfaat Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

Asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga (Patient and Family Centered Care/PFCC) memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pasien, keluarga, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, yaitu:

a. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan

Asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan dengan melibatkan keluarga dalam setiap proses perawatan. Hal ini membuat intervensi keperawatan lebih sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Keterlibatan keluarga juga membantu perawat memperoleh informasi yang lebih akurat sehingga asuhan yang diberikan menjadi lebih tepat, aman, dan bermutu.

b. Memperkuat hubungan perawat–pasien–keluarga

Pendekatan ini mendorong komunikasi terbuka, saling menghargai, dan kerja sama antara perawat, pasien, dan keluarga. Dengan dilibatkan secara aktif, keluarga merasa dihargai dan dipercaya, sehingga terbentuk hubungan terapeutik yang lebih baik. Hubungan yang harmonis ini meningkatkan rasa percaya pasien dan keluarga terhadap perawat serta pelayanan kesehatan.

c. Menurunkan angka kesalahan dan kejadian tidak diharapkan

Keluarga yang terlibat dalam perawatan dapat berperan sebagai pengawas tambahan, misalnya dalam pemberian obat, pemantauan kondisi pasien, dan pelaporan perubahan status kesehatan. Dengan adanya kolaborasi ini, potensi

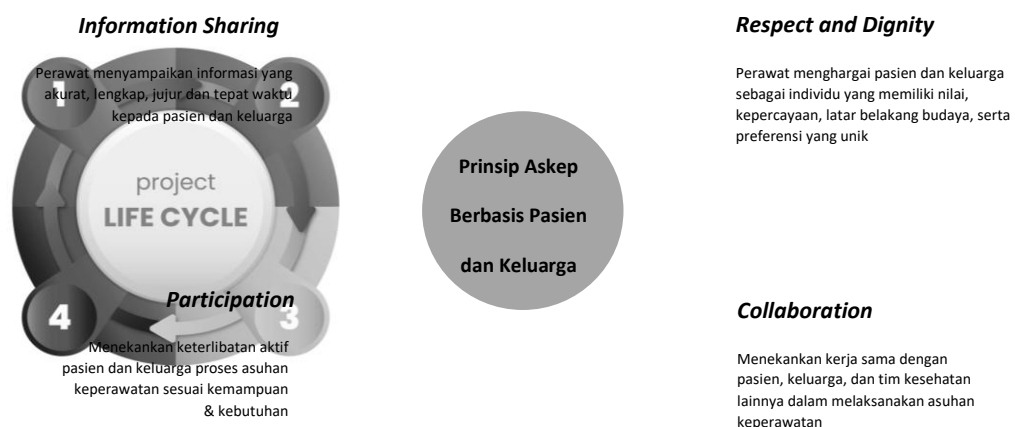
kesalahan dapat dideteksi lebih dini sehingga risiko kejadian tidak diharapkan dapat diminimalkan.

d. Membantu kesinambungan perawatan di rumah

Melalui edukasi dan keterlibatan sejak awal, keluarga menjadi lebih memahami kondisi pasien, rencana perawatan, serta tindakan yang perlu dilakukan setelah pasien pulang. Hal ini memudahkan keluarga melanjutkan perawatan di rumah secara mandiri dan konsisten, sehingga proses penyembuhan lebih optimal dan risiko kekambuhan atau komplikasi dapat dikurangi.

C. Prinsip Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga merupakan pendekatan pelayanan keperawatan yang menempatkan pasien dan keluarganya sebagai mitra utama dalam proses perawatan. Pendekatan ini didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu rasa hormat dan martabat, berbagi informasi, partisipasi, dan kolaborasi.



Gambar 3.1 Prinsip Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

1. Rasa Hormat dan Martabat (Respect and Dignity)

Prinsip rasa hormat dan martabat menekankan bahwa perawat harus menghargai pasien dan keluarganya sebagai individu yang memiliki nilai, kepercayaan, latar belakang budaya, serta preferensi yang unik. Dalam praktik keperawatan, perawat wajib menjaga martabat pasien dengan memperlakukan pasien secara manusiawi, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak pasien. Setiap tindakan dan keputusan keperawatan harus mempertimbangkan keinginan serta nilai yang dianut oleh pasien dan keluarga. Dengan menghormati martabat pasien dan keluarga, perawat dapat membangun hubungan terapeutik yang didasari oleh kepercayaan dan rasa aman, sehingga pasien merasa dihargai dan dilibatkan secara utuh dalam proses perawatan.

2. Berbagi Informasi (*Information Sharing*)

Prinsip berbagi informasi mengharuskan perawat untuk menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, dan tepat waktu kepada pasien dan keluarga. Informasi yang diberikan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan tingkat pendidikan dan kondisi pasien serta keluarga. Melalui pemberian informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan, rencana perawatan, tindakan keperawatan, serta kemungkinan risiko dan hasil yang diharapkan, pasien dan keluarga dapat memahami situasi yang dihadapi dan membuat keputusan secara sadar. Berbagi informasi juga mencakup keterbukaan perawat untuk mendengarkan pertanyaan, pendapat, dan kekhawatiran pasien serta keluarga sebagai bagian dari proses komunikasi dua arah.

3. Partisipasi (*Participation*)

Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam seluruh proses asuhan keperawatan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan keinginan mereka. Pasien dan keluarga didorong untuk berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan keperawatan, serta pemantauan hasil perawatan. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan keluarga dalam perawatan dasar pasien, pemberian dukungan emosional, maupun kepatuhan terhadap terapi yang telah disepakati. Dengan adanya partisipasi aktif, pasien dan keluarga akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses penyembuhan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberhasilan asuhan keperawatan.

4. Kolaborasi (*Collaboration*)

Prinsip kolaborasi menekankan kerja sama antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan. Kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan pandangan dan pengalaman pasien serta keluarga ke dalam pengambilan keputusan klinis dan perencanaan perawatan. Perawat berperan sebagai koordinator yang memastikan komunikasi efektif antar anggota tim kesehatan serta menjembatani kebutuhan pasien dan keluarga. Melalui kolaborasi yang baik, pelayanan kesehatan menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan berfokus pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

D. Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

Pendekatan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga diterapkan dalam setiap tahap proses keperawatan:

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dalam asuhan keperawatan keluarga berbasis pasien dan keluarga. Pada pendekatan PFCC, pengkajian tidak hanya berfokus pada kondisi fisik pasien, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai sumber data utama. Perawat melakukan pengkajian secara holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien serta keluarga. Selain itu, perawat mengkaji struktur dan fungsi keluarga, peran anggota keluarga, kemampuan keluarga dalam merawat pasien, serta nilai dan preferensi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Proses pengkajian dilakukan melalui komunikasi terbuka, saling menghargai, dan melibatkan keluarga secara aktif agar data yang diperoleh akurat dan komprehensif.

2. Penetapan Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan data hasil pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada masalah pasien, tetapi juga pada respons keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Dalam pendekatan PFCC, diagnosis keperawatan dapat mencerminkan kebutuhan edukasi, dukungan, dan kemampuan keluarga dalam merawat pasien, seperti kurangnya pengetahuan keluarga tentang penyakit atau ketidakefektifan coping keluarga. Penetapan diagnosis dilakukan bersama pasien dan keluarga sebagai bentuk kolaborasi, sehingga diagnosis yang ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata serta dapat diterima oleh pasien dan keluarga.

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan dalam asuhan keperawatan keluarga berbasis pasien dan keluarga disusun secara kolaboratif antara perawat, pasien, dan keluarga. Perawat menetapkan tujuan dan kriteria hasil yang realistis, terukur, serta sesuai dengan kemampuan dan sumber daya keluarga. Rencana keperawatan mencakup intervensi yang tidak hanya berfokus pada tindakan keperawatan kepada pasien, tetapi juga pemberdayaan keluarga melalui edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan perawatan, dan dukungan emosional. Keterlibatan keluarga dalam perencanaan diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian keluarga dalam proses perawatan (Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2017).

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan tahap pelaksanaan rencana keperawatan yang telah disepakati bersama pasien dan keluarga. Dalam

pendekatan PFCC, perawat berperan sebagai fasilitator dan pendamping yang mendukung keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan pasien. Implementasi dapat berupa tindakan keperawatan langsung, pemberian edukasi kesehatan, bimbingan kepada keluarga, serta pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Perawat juga menjaga komunikasi yang efektif dan saling menghormati agar pasien dan keluarga merasa dihargai sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan asuhan keperawatan telah tercapai. Dalam asuhan keperawatan keluarga berbasis pasien dan keluarga, evaluasi tidak hanya menilai perubahan kondisi kesehatan pasien, tetapi juga peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keluarga dalam merawat pasien. Proses evaluasi dilakukan bersama pasien dan keluarga dengan mempertimbangkan umpan balik mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan rencana keperawatan agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga.

Ilustrasi Kasus Penerapan Asuhan Keperawatan Keluarga Berbasis Pasien dan Keluarga (PFCC)

Tn. A (55 tahun) dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis Diabetes Melitus tipe 2 disertai luka kaki diabetik. Pasien tinggal bersama istri dan dua orang anak. Selama perawatan, pasien tampak cemas terhadap kondisinya dan kurang memahami cara perawatan luka serta pengaturan diet. Istri pasien menyatakan belum mengetahui cara merawat luka di rumah dan merasa takut melakukan kesalahan dalam perawatan.

a. Pengkajian Keperawatan

Perawat melakukan pengkajian dengan melibatkan Tn. A dan keluarganya. Data yang diperoleh meliputi kondisi fisik pasien, tingkat nyeri, kondisi luka, serta kadar gula darah. Selain itu, perawat mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit diabetes, perawatan luka, pola makan, serta kemampuan keluarga dalam mendukung perawatan di rumah. Dari hasil pengkajian psikososial, diketahui bahwa keluarga bersedia terlibat aktif namun masih kurang percaya diri dan membutuhkan bimbingan.

b. Penetapan Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan data pengkajian, perawat menetapkan beberapa diagnosis keperawatan, antara lain:

- 1) Kurang pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan diabetes dan luka kaki diabetik berhubungan dengan kurangnya informasi.
- 2) Ansietas pasien berhubungan dengan kondisi penyakit dan ketidakpastian proses penyembuhan.
- 3) Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan motivasi keluarga untuk terlibat dalam perawatan pasien.

Diagnosis ini didiskusikan bersama pasien dan keluarga agar mereka memahami masalah yang dihadapi dan tujuan asuhan keperawatan.

c. Perencanaan Keperawatan

Perawat bersama pasien dan keluarga menyusun rencana keperawatan dengan tujuan agar pasien dan keluarga mampu memahami penyakit diabetes, melakukan perawatan luka secara mandiri, serta mengontrol kadar gula darah dengan baik. Rencana keperawatan meliputi pemberian edukasi tentang diabetes, diet yang tepat, teknik perawatan luka kaki diabetik, serta tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai. Keluarga dilibatkan dalam penentuan waktu edukasi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

d. Implementasi Keperawatan

Pada tahap implementasi, perawat memberikan edukasi kesehatan secara bertahap kepada pasien dan keluarga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Perawat mendemonstrasikan cara membersihkan dan merawat luka kaki diabetik, kemudian meminta istri pasien untuk melakukan redemonstrasi. Selain itu, perawat memberikan dukungan emosional kepada pasien untuk mengurangi kecemasan serta mendorong keluarga agar terus memberikan motivasi dan pendampingan selama proses perawatan. Seluruh tindakan dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan menghargai peran pasien serta keluarga sebagai mitra perawatan.

e. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan dengan melibatkan pasien dan keluarga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali cara perawatan luka dan prinsip pengaturan diet diabetes. Istri pasien terlihat lebih percaya diri dalam melakukan perawatan luka, dan kecemasan pasien berkurang. Kadar gula darah pasien mulai terkontrol dan kondisi luka menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perawat menyimpulkan bahwa tujuan asuhan keperawatan sebagian besar telah tercapai dan rencana perawatan dapat dilanjutkan dengan pemantauan serta edukasi lanjutan.

E. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

Dalam asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga, perawat memiliki peran strategis sebagai tenaga profesional yang berinteraksi langsung dan berkesinambungan dengan pasien serta keluarganya. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan berpusat pada kebutuhan pasien dan keluarga secara holistik.

a. Pemberi asuhan keperawatan

Perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan melaksanakan proses keperawatan secara komprehensif, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dalam peran ini, perawat mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien serta melibatkan keluarga dalam setiap tahap asuhan. Asuhan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pasien, tetapi juga pada upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien.

b. Edukator bagi pasien dan keluarga

Sebagai edukator, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga terkait kondisi kesehatan, tindakan keperawatan, penggunaan obat, serta perawatan lanjutan di rumah. Edukasi disampaikan secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan serta kemampuan pasien dan keluarga. Melalui edukasi yang efektif, pasien dan keluarga diharapkan mampu memahami kondisi yang dialami, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, serta mengembangkan kemandirian dalam merawat kesehatan. Perawat harus memiliki kemampuan komunikasi terapeutik, empati, serta sikap profesional dalam membangun hubungan saling percaya.

c. Fasilitator komunikasi

Perawat berperan sebagai fasilitator komunikasi dengan menjembatani interaksi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Perawat memastikan bahwa informasi yang diterima pasien dan keluarga jelas, akurat, dan konsisten. Selain itu, perawat juga menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan keluhan pasien serta keluarga kepada tim kesehatan, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan saling menghargai.

d. Advokat pasien dan keluarga

Dalam peran sebagai advokat, perawat melindungi hak dan kepentingan pasien serta keluarganya. Perawat membantu pasien dan keluarga dalam memahami pilihan pelayanan kesehatan, mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka, serta memastikan bahwa pelayanan yang

diberikan sesuai dengan standar dan etika profesi. Peran advokasi ini penting untuk menjamin keselamatan pasien, menghormati otonomi pasien, dan mencegah terjadinya perlakuan yang merugikan pasien.

e. Koordinator pelayanan kesehatan

Perawat berperan sebagai koordinator pelayanan kesehatan dengan mengatur dan menyinergikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan pasien. Perawat bekerja sama dengan dokter, tenaga kesehatan lain, serta keluarga untuk memastikan kesinambungan dan keterpaduan perawatan. Koordinasi ini mencakup perencanaan perawatan, rujukan, serta persiapan pemulangan pasien, sehingga pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

F. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam penerapan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga adalah:

a. Komitmen tenaga kesehatan

Komitmen tenaga kesehatan khususnya perawat, dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Sikap profesional, empati, serta kemampuan komunikasi yang baik dari perawat dapat membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, dan keluarga. Kepercayaan ini menjadi dasar penting untuk melibatkan keluarga secara aktif dalam proses perawatan.

b. Dukungan kebijakan

Dukungan kebijakan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan menjadi faktor pendukung yang signifikan. Adanya standar operasional prosedur (SOP), pedoman praktik keperawatan, serta kebijakan rumah sakit yang mendorong keterlibatan pasien dan keluarga akan mempermudah penerapan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang tunggu keluarga dan akses informasi yang jelas, turut menunjang keberhasilan pendekatan ini.

c. Pendidikan dan pengetahuan pasien serta keluarga

Pendidikan dan pengetahuan pasien dan keluarga terkait kondisi kesehatan dan proses perawatan juga berperan penting sebagai faktor pendukung. Pasien dan keluarga yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih kooperatif, aktif bertanya, dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu perawat dalam menyusun dan

melaksanakan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Beban kerja perawat yang tinggi, rasio perawat dan pasien yang tidak seimbang, serta keterbatasan waktu dapat menghambat perawat dalam melakukan komunikasi dan edukasi secara optimal kepada pasien dan keluarga.

b. Perbedaan Latar Belakang Budaya dan Pendidikan

Perbedaan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, serta persepsi pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan juga dapat menjadi hambatan. Kurangnya pemahaman keluarga mengenai peran mereka dalam perawatan atau adanya keyakinan yang bertentangan dengan prinsip medis dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi antara perawat dan keluarga.

c. Kurangnya Dukungan Organisasi

Kurangnya dukungan dari organisasi serta belum optimalnya penerapan kebijakan PFCC di fasilitas kesehatan turut menjadi faktor penghambat. Tidak adanya pelatihan khusus mengenai PFCC, minimnya sosialisasi, serta sikap tenaga kesehatan yang masih berorientasi pada pelayanan tradisional dapat menghambat implementasi asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga secara efektif dan berkelanjutan.

G. Simpulan

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga (*Patient and Family Centered Care*/PFCC) merupakan pendekatan pelayanan keperawatan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat serta mitra aktif dalam seluruh proses asuhan keperawatan. Pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap nilai, kepercayaan, budaya, dan preferensi pasien serta keluarga melalui komunikasi terbuka, partisipasi aktif, dan kolaborasi yang berkesinambungan antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan.

Penerapan PFCC memberikan berbagai manfaat untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, mempercepat proses penyembuhan, serta mendukung kesinambungan perawatan baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi dalam menurunkan kecemasan

pasien dan keluarga serta meningkatkan kemandirian mereka dalam pengelolaan kesehatan.

Keberhasilan penerapan asuhan keperawatan berbasis pasien dan keluarga sangat dipengaruhi oleh peran perawat sebagai pemberi asuhan, edukator, fasilitator komunikasi, advokat, dan koordinator pelayanan kesehatan. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti komitmen tenaga kesehatan, dukungan kebijakan, serta pengetahuan pasien dan keluarga, penerapan PFCC juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan, serta kurangnya dukungan organisasi. Dengan demikian, penerapan Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga perlu didukung secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi perawat, penguatan kebijakan institusi, serta edukasi kepada pasien dan keluarga agar pelayanan keperawatan yang diberikan dapat berlangsung secara holistik, humanis, aman, dan bermutu.

H. Referensi

- Anderson, R. M., & Funnell, M. M. (2010). *Patient empowerment: Myths and misconceptions*. *Patient Education and Counseling*, 79(3), 277–282.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gilliss, C. L., & Davis, L. L. (2017). *Family Nursing: A Guide to Theory, Practice, and Research*. New York: Springer Publishing Company.
- Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2017). *Advancing the practice of patient- and family-centered care*. Bethesda, MD: IPFCC.
- Joint Commission International. (2018). *Patient-Centered Care Standards*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Standar pelayanan keperawatan di rumah sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Shields, L., Zhou, H., Pratt, J., Taylor, M., Hunter, J., & Pascoe, E. (2012). Family-centred care for hospitalised children aged 0–12 years. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (10).
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2016). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community*. St. Louis: Elsevier.

- Stuart, G. W. (2016). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. St. Louis: Elsevier.
- Sulistyo, A., & Widyastuti, Y. (2019). Penerapan *Patient and Family Centered Care* dalam pelayanan keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(2), 85–92.
- World Health Organization. (2016). *Framework on integrated, people-centred health services*. Geneva: WHO.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan

Rangkaian kegiatan keperawatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien.

Asuhan Keperawatan Berbasis Pasien dan Keluarga atau *Patient and Family Centered Care* (PFCC)

Pendekatan pelayanan keperawatan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat serta mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan yang menekankan rasa saling menghormati, berbagi informasi, partisipasi, dan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga.

Keluarga

Sekelompok individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau emosional yang berperan sebagai pendukung utama pasien dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan.

Kolaborasi

Kerja sama antara perawat, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya dalam merencanakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Partisipasi

Keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan perawatan, serta pemantauan hasil asuhan keperawatan.

Komunikasi Terapeutik

Proses komunikasi yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk membantu pasien dan keluarga dalam mencapai kesehatan yang optimal.

Holistik

Pendekatan pelayanan yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual pasien serta keluarganya.

Advokasi

Peran perawat dalam melindungi hak, kepentingan, dan keselamatan pasien serta keluarga dalam proses pelayanan kesehatan.

Kesinambungan Perawatan (*Continuity of Care*)

Proses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dari fasilitas kesehatan hingga perawatan di rumah.

CHAPTER 4

PENDEKATAN GIZI BERBASIS PASIEN DAN KELUARGA

Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Transformasi sistem kesehatan global dalam dua dekade terakhir menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat dari seluruh proses pelayanan. Pergeseran paradigma dari model paternalistik menuju *patient- and family-centered care* (PFCC) didorong oleh akumulasi bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pasien dan keluarga berhubungan erat dengan peningkatan keselamatan pasien, mutu layanan, dan efisiensi sistem kesehatan (*World Health Organization* [WHO], 2021; Epstein & Street, 2019).

Laporan WHO tentang *People-Centred and Integrated Health Services* menyatakan bahwa sistem kesehatan yang berorientasi pada pasien dan keluarga mampu menurunkan kejadian *adverse events* hingga 15–30% melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama (WHO, 2021). Sejalan dengan itu, *National Academy of Medicine* (2021) menegaskan bahwa pelayanan yang mengintegrasikan perspektif pasien dan keluarga merupakan salah satu pilar utama peningkatan mutu dan keselamatan layanan kesehatan secara global.

Bukti empiris dari berbagai penelitian menunjukkan dampak signifikan PFCC terhadap luaran klinis dan pengalaman pasien. Meta-analisis oleh Shields *et al.* (2020) pada lebih dari 20 studi menemukan bahwa penerapan family-centered care pada pelayanan rumah sakit berhubungan dengan peningkatan kepuasan pasien dan keluarga sebesar 20–40%, serta penurunan lama rawat inap rata-rata 0,5–1,5 hari. Penelitian sistematis lain melaporkan bahwa pendekatan PFCC meningkatkan kepatuhan pengobatan pada penyakit kronis sebesar 15–25% dibandingkan model pelayanan konvensional (Kokorelias *et al.*, 2019).

Dalam konteks keselamatan pasien, studi observasional multisenter di Amerika Utara dan Eropa menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam *clinical rounds* dan perencanaan perawatan menurunkan kejadian kesalahan medis hingga 17% serta meningkatkan deteksi dini perubahan kondisi klinis pasien (Johnson *et al.*, 2020). Selain itu, *shared decision making* yang merupakan komponen utama PFCC terbukti meningkatkan kualitas keputusan klinis tanpa meningkatkan beban waktu konsultasi secara bermakna (Elwyn *et al.*, 2020).

Di Indonesia, agenda Transformasi Sistem Kesehatan menekankan pentingnya pelayanan yang berfokus pada kebutuhan individu dan keluarga, terutama dalam

penguatan pelayanan kesehatan primer dan pengelolaan penyakit kronis (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Tantangan seperti beban penyakit tidak menular, penuaan penduduk, dan keterbatasan sumber daya menuntut tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan kemitraan dengan pasien dan keluarga sebagai bagian integral dari praktik profesional.

Berdasarkan data dan hasil penelitian tersebut, PFCC bukan hanya pendekatan normatif, tetapi strategi berbasis bukti (*evidence-based strategy*) yang relevan untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman konseptual dan keterampilan praktis tenaga kesehatan dalam menerapkan pelayanan berbasis pasien dan keluarga menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik pelayanan kesehatan modern lintas profesi.

Tabel 4.1 Ringkasan Temuan Penelitian tentang Dampak Patient- and Family-Centered Care

Aspek yang Dinilai	Temuan Utama	Sumber Penelitian
Keselamatan pasien	Penurunan <i>adverse events</i> 15–30%	WHO (2021)
Kepuasan pasien & keluarga	Peningkatan 20–40%	Shields <i>et al.</i> (2020)
Lama rawat inap	Penurunan 0,5–1,5 hari	Shields <i>et al.</i> (2020)
Kepatuhan pengobatan	Peningkatan 15–25%	Kokorelias <i>et al.</i> (2019)
Kesalahan medis	Penurunan hingga 17%	Johnson <i>et al.</i> (2020)
Kualitas pengambilan keputusan	Meningkat signifikan tanpa menambah waktu konsultasi	Elwyn <i>et al.</i> (2020)

Pendekatan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga (*Patient- and Family-Centered Nutrition Care/PFCNC*) merupakan pengembangan dari konsep patient- and family-centered care yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses asuhan gizi. Pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap nilai, preferensi, budaya, serta konteks sosial keluarga dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi intervensi gizi (*Institute for Patient- and Family-Centered Care* [IPFCC], 2022).

Secara global, masalah gizi—baik kekurangan gizi, kelebihan gizi, maupun penyakit tidak menular terkait diet—masih menjadi tantangan utama sistem

kesehatan. *Global Nutrition Report* menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 45 juta anak balita mengalami *wasting*, 148 juta mengalami *stunting*, sementara prevalensi obesitas pada orang dewasa meningkat hampir tiga kali lipat sejak 1975 (*Development Initiatives*, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tidak mempertimbangkan keterlibatan keluarga sering kali menghasilkan kepatuhan rendah dan luaran klinis yang kurang optimal (Odoms-Young *et al.*, 2019).

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, pendekatan gizi berbasis pasien dan keluarga terbukti meningkatkan kepatuhan diet, kualitas hidup, serta keberlanjutan perubahan perilaku makan, khususnya pada pasien penyakit kronis seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan malnutrisi pada lansia (Kokorelias *et al.*, 2019).

B. Konsep dan Prinsip Pendekatan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga

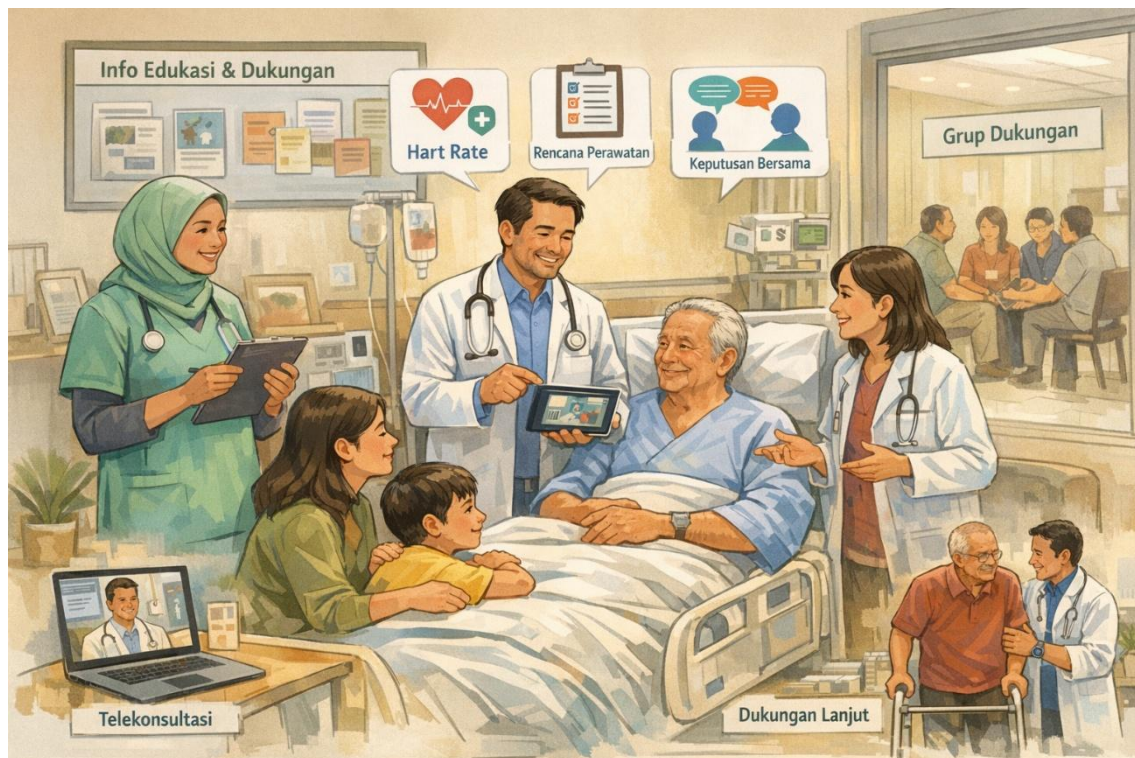
Pendekatan gizi berbasis pasien dan keluarga didefinisikan sebagai pendekatan pelayanan gizi yang menghormati dan merespons preferensi, kebutuhan, serta nilai pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan klinis (*Institute for Patient- and Family-Centered Care* [IPFCC], 2022; WHO, 2021).

Empat prinsip inti PFCC yang diakui secara internasional meliputi (IPFCC, 2022; Johnson *et al.*, 2020):

- 1. Martabat dan rasa hormat:** Tenaga kesehatan mendengarkan dan menghargai perspektif serta pilihan pasien dan keluarga.
- 2. Berbagi informasi:** Informasi klinis disampaikan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami.
- 3. Partisipasi:** Pasien dan keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan dan pengambilan keputusan.
- 4. Kolaborasi:** Pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

Dalam praktik gizi, prinsip ini diwujudkan melalui pengkajian kebutuhan gizi yang holistik, diskusi terbuka mengenai pilihan intervensi diet, serta pengambilan keputusan bersama antara tenaga gizi, pasien, dan keluarga.

Penelitian sistematis oleh Sladdin *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam konseling gizi meningkatkan pemahaman pasien terhadap rencana diet sebesar 20–30% dibandingkan pendekatan tradisional yang bersifat instruktif.



Gambar 4.1

C. Dasar Teoretis dan *Evidence-Based Practice*

Praktik gizi berbasis bukti (*evidence-based nutrition practice*) dalam konteks pasien dan keluarga mengintegrasikan tiga komponen utama: (1) bukti ilmiah terbaik dari penelitian berkualitas tinggi, (2) keahlian profesional tenaga gizi, dan (3) nilai, preferensi, serta konteks keluarga pasien (*Academy of Nutrition and Dietetics*, 2021). Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi gizi tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga realistis dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari pasien.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pasien dan keluarga secara aktif dalam perencanaan dan pemantauan intervensi gizi memberikan dampak signifikan terhadap luaran klinis dan perilaku. Meta-analisis dan studi multisenter pada berbagai kelompok pasien menegaskan bahwa pendekatan ini lebih unggul dibandingkan konseling gizi konvensional yang bersifat satu arah.

Tabel 4.2 Bukti Ilmiah Evidence-Based Practice dalam Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga

Populasi & Setting	Desain & Sumber Penelitian	Bentuk Keterlibatan Pasien & Keluarga	Luaran Klinis Utama (Angka)
Diabetes melitus tipe 2 (primer & komunitas)	Meta-analisis 15 RCT (Baig et al., 2015; update)	Edukasi diet berbasis keluarga, pemantauan asupan bersama	Penurunan HbA1c 0,5–1,0%; kepatuhan diet ↑ 20–30%

	direplikasi pada studi 2019–2022)		
Penyakit kardiovaskular (rawat jalan)	Systematic review (Odoms-Young et al., 2019)	Perencanaan menu keluarga, goal setting bersama	Penurunan LDL 10–15 mg/dL; kepatuhan diet rendah lemak ↑ 25%
Lansia berisiko malnutrisi (rumah & panti)	Multicenter cohort (Sharma et al., 2021)	Keluarga terlibat dalam pemilihan menu & monitoring	Asupan energi & protein ↑ 15–25%; rawat inap ulang ↓ 20%
Anak balita (Asia & Afrika)	Studi lintas negara & kohort (Ruel et al., 2020)	Edukasi gizi ibu & keluarga inti	Risiko stunting ↓ hingga 18%; keberagaman pangan ↑ signifikan
Pasien kanker (rawat jalan)	RCT multicenter (Volkert et al., 2019; ESPEN)	Konseling gizi bersama caregiver	Status gizi membaik; kualitas hidup ↑ ($p < 0,01$)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pendekatan gizi berbasis pasien dan keluarga secara konsisten memberikan perbaikan bermakna secara klinis pada indikator metabolik, status gizi, kepatuhan diet, dan kualitas hidup. Temuan ini menegaskan bahwa *evidence-based practice* dalam gizi harus melampaui pemberian rekomendasi nutrisi semata dan mencakup strategi komunikasi, pengambilan keputusan bersama, serta dukungan keluarga yang berkelanjutan.

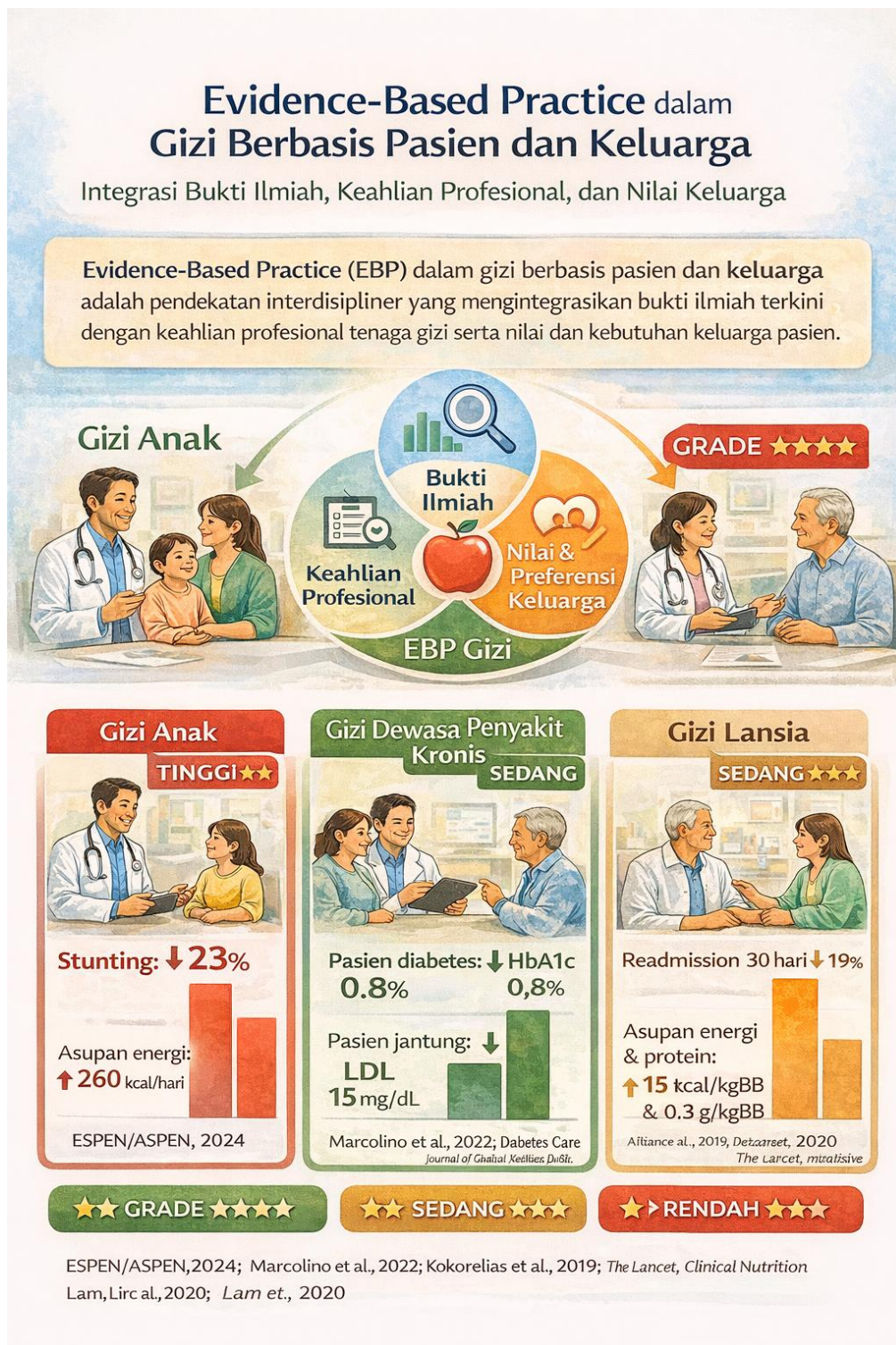
D. Pendekatan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga pada Berbagai Siklus Kehidupan

Pada anak dan remaja, keluarga berperan sebagai penentu utama pola makan. Studi kohort di Asia Pasifik menunjukkan bahwa edukasi gizi berbasis keluarga menurunkan risiko stunting hingga 18% dan meningkatkan keberagaman pangan rumah tangga (Ruel *et al.*, 2020).

Berdasarkan Wijayanti dkk (2019), rendahnya pemahaman orang tua dalam pola asuh pemberian makan pada anak kurang diperhatikan, sehingga menyebabkan status gizi anak kurang atau bahkan berlebih yang tidak sesuai dengan usia maupun tinggi badannya. Melalui pelatihan hypnoparenting orang tua dapat mengubah pola asuhnya dengan baik dan benar serta dapat meningkatkan status gizi balita.

Pada pasien dewasa dan penyakit kronis, pendekatan ini membantu adaptasi diet jangka panjang. Sementara itu, pada lansia, pendekatan berbasis keluarga

mendukung pencegahan sarkopenia dan penurunan fungsi dengan menyesuaikan kebutuhan gizi, preferensi rasa, dan kemampuan makan (Volkert et al., 2019).

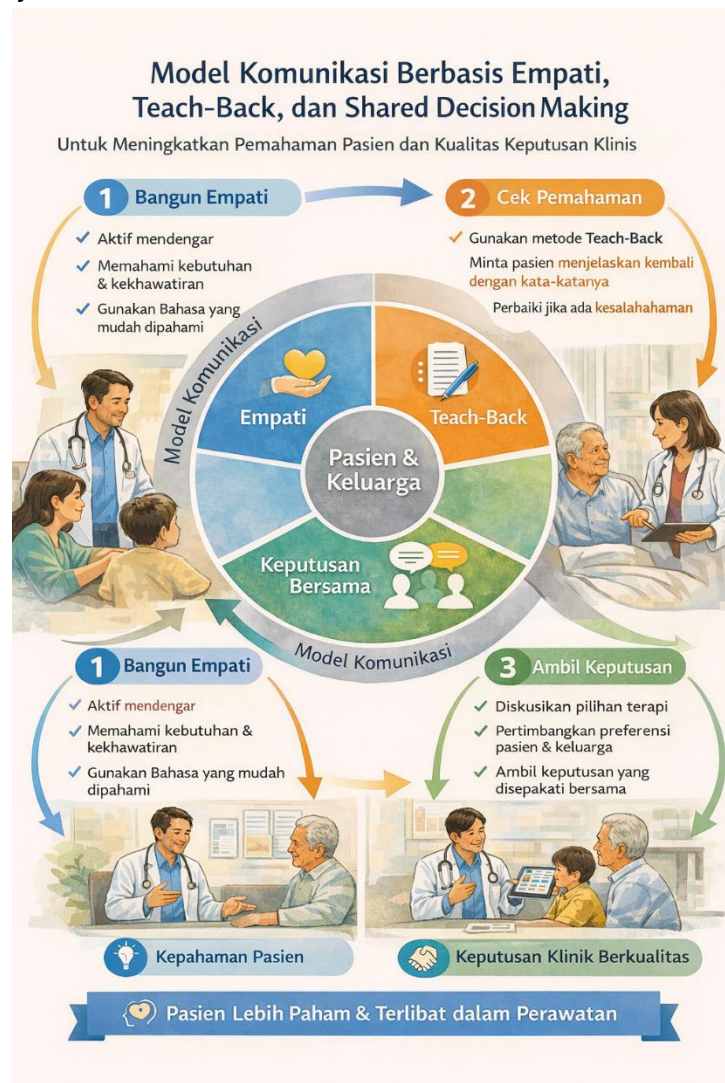


Gambar 4.2 Evidence Based Practice dalam gizi berbasis pasien dan keluarga

E. Implementasi Pelayanan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan

1. Komunikasi Terapeutik dan Pengambilan Keputusan Bersama

Komunikasi efektif merupakan fondasi PFCC dan menjadi determinan utama keberhasilan keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan (Elwyn et al., 2020; Ha Dinh et al., 2016). Model komunikasi berbasis empati, *teach-back*, dan *shared decision making* terbukti meningkatkan pemahaman pasien serta kualitas keputusan klinis. Studi terkini menunjukkan bahwa penggunaan *decision aids* berbasis bukti dapat meningkatkan keterlibatan pasien tanpa meningkatkan beban waktu konsultasi secara signifikan. Strategi yang direkomendasikan meliputi penggunaan *nutrition decision aids*, konseling berbasis empati dan *teach-back*, serta kolaborasi interprofesional antara dietisien, dokter, perawat, dan keluarga (Elwyn et al., 2017).



Gambar 4.3 Model Komunikasi Berbasis empati teach back dan shared decision making

Decision Aids: Alat Bantu Pengambilan Keputusan

Menyediakan Informasi yang Jelas, Imbang, dan Berbasis Bukti



Gambar 4.4 Decision Aids



Gambar 4.5 Nutrition Decision Aids

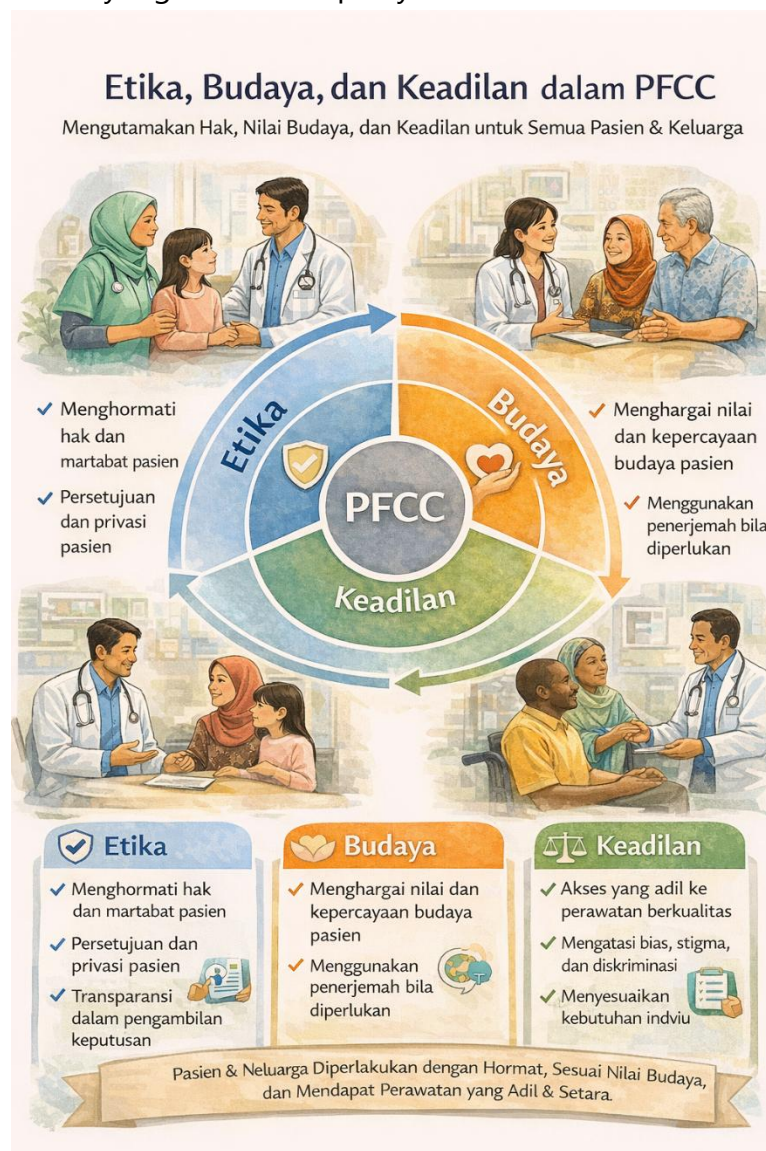
2. Peran Keluarga dalam Kontinum Pelayanan

Keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam perawatan di rumah, pemantauan kepatuhan terapi, dan pemulihan pasien, terutama pada pasien

dengan penyakit kronis, anak, dan lansia (Kokorelias et al., 2019; Shields *et al.*, 2020). Bukti penelitian menunjukkan bahwa pelibatan keluarga secara terstruktur menurunkan angka rawat ulang dan meningkatkan kualitas hidup pasien, khususnya pada penyakit tidak menular dan kondisi geriatri.

3. Etika, Budaya, dan Keadilan dalam PFCC

Penerapan PFCC harus sensitif terhadap nilai budaya, agama, dan konteks sosial pasien, karena faktor-faktor tersebut memengaruhi persepsi sakit, pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap terapi (Beauchamp & Childress, 2019; Kleinman & Benson, 2020). Prinsip keadilan dan inklusivitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang setara dari pelayanan kesehatan.



Gambar 4.6 Etika, Budaya, dan Keadilan dalam PFCC

F. Tantangan, Inovasi, dan Masa Depan Pelayanan Gizi Berbasis Pasien dan Keluarga

1. Tantangan Implementasi

Tantangan utama meliputi keterbatasan waktu, beban kerja tenaga kesehatan, variasi literasi gizi pasien, serta sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan kolaboratif (Luxford *et al.*, 2011; *National Academy of Medicine*, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, dan kepemimpinan klinis berperan penting dalam keberhasilan implementasi PFCC.

2. Peran Teknologi dan Kesehatan Digital

Pemanfaatan rekam medis elektronik, *telehealth*, dan aplikasi kesehatan berbasis pasien memperluas peluang keterlibatan pasien dan keluarga dalam perencanaan dan pemantauan layanan gizi (WHO, 2022; Kruse *et al.*, 2022). Studi pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dengan prinsip PFCC meningkatkan akses dan kontinuitas pelayanan.

3. Arah Kebijakan dan Pengembangan SDM Kesehatan

Pengarusutamaan PFCC dalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, standar akreditasi, dan kebijakan nasional merupakan langkah strategis untuk keberlanjutan pendekatan ini.

G. Simpulan

Pendekatan gizi berbasis pasien dan keluarga merupakan strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas asuhan gizi yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pasien dan keluarga tidak hanya memperbaiki luaran klinis, tetapi juga meningkatkan kepuasan, kualitas hidup, dan keberhasilan perubahan perilaku makan jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi pendekatan ini perlu menjadi standar dalam praktik tenaga gizi dan pelayanan kesehatan di berbagai setting.

H. Referensi

- Academy of Nutrition and Dietetics. (2021). Evidence-based nutrition practice guidelines. <https://www.eatright.org>
- Baig, A. A., Benitez, A., Quinn, M. T., & Burnet, D. L. (2015). Family interventions to improve diabetes outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes Care*, 38 (8), 1517–1526. <https://doi.org/10.2337/dc15-0182>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Development Initiatives. (2023). *Global Nutrition Report 2023*. <https://globalnutritionreport.org>
- Elwyn, G., et al. (2020). A three-talk model for shared decision making. *BMJ*, 359, j4891. <https://doi.org/10.1136/bmj.j4891>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... Barry, M. (2017). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27 (10), 1361–1367. [<https://doi.org/10.1007/s11606-012-20776>](<https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>)
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2019). The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, 17 (1), 15–20. <https://doi.org/10.1370/afm.2331>
- Frenk, J., et al. (2019). Health professionals for a new century. *The Lancet*, 393 (10179), 1923–1958.
- Ha Dinh, T. T., et al. (2016). The effectiveness of the teach-back method. *Journal of Communication in Healthcare*, 9 (3), 190–196. <https://doi.org/10.1080/17538068.2016.1234012>
- Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2022). *Advancing the practice of patient- and family-centered care*. <https://www.ipfcc.org>
- Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2022). What is patient- and family-centered care? <https://www.ipfcc.org>](<https://www.ipfcc.org>)
- Johnson, B., et al. (2020). Partnering with patients and families to design a patient-

and family-centered health care system. *Journal of Nursing Administration*, 50 (2), 63–69.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Cetak biru transformasi sistem kesehatan Indonesia. Kemenkes RI.

Kleinman, A., & Benson, P. (2020). Anthropology in the clinic. *PLoS Medicine*, 17 (10), e1003134.

Kokorelias, K. M., et al. (2019). Family-centered care in chronic disease management. *Patient Education and Counseling*, 102 (1), 90–99. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.006>

Kokorelias, K. M., Gignac, M. A. M., Naglie, G., & Cameron, J. I. (2019). Towards a universal model of family centered care: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 19, 564. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4394-5>

Kruse, C. S., et al. (2022). Telemedicine and patient satisfaction. *BMJ Open*, 12 (2), e052219.

Luxford, K., et al. (2011). Promoting patient-centred care. *International Journal for Quality in Health Care*, 23 (5), 513–520.

McCormack, B., & McCance, T. (2021). *Person-centred practice in nursing and health care* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

National Academy of Medicine. (2021). *Crossing the global quality chasm*. The National Academies Press.

Odoms-Young, A., Bruce, M. A., & Alia, K. A. (2019). Nutrition education and family engagement. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 51 (6), 699–708. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.03.004>

Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2020). Nutrition-sensitive interventions and programmes. *The Lancet*, 382 (9891), 536–551. [[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60920-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60920-8)](<https://doi.org/10.1016/S0140-6736%2813%2960920-8>)

Sharma, Y., Thompson, C., & Miller, M. (2021). Family involvement in nutritional care of older adults. *Clinical Nutrition*, 40 (5), 2596–2604. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.11.020>

0.11.020)

Shields, L., et al. (2020). Family-centred care: A review. *Journal of Clinical Nursing*, 29 (3–4), 407–421. https://doi.org/10.1111/jocn.15199

Sladdin, I., Ball, L., Gillespie, B. M., Chaboyer, W., & Mitchell, M. (2020). Patient-centred care to improve dietetic outcomes. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 33 (4), 547–556. https://doi.org/10.1111/jhn.12755

Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., Hooper, L., ... Bischoff, S. C. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 38 (1), 10–47. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024

WHO. (2022). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.

Wijayanti, H. N., Dewi, D. C., & Nurtyas, M. (2019, November). Pengaruh hypnoparenting terhadap peningkatan status gizi pada balita. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu* (Vol. 1, No. 2, pp. 238-241).

World Health Organization. (2021). *Global strategy on people-centred and integrated health services*. WHO Press.

World Health Organization. (2023). *Primary health care measurement and improvement*. WHO Press.

I. Glosarium

PFCC	= <i>Patient- and Family-Centered Care</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>
IPFCC	= <i>Institute for Patient- and Family-Centered Care</i>
PFCNC	= <i>Patient- and Family-Centered Nutrition Care</i>
SDM	= Sumber Daya Manusia

CHAPTER 5

PERAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA

Dr. Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

A. Pendahuluan / Prolog

Kesehatan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Dhingra & Dabas, 2020). Dalam konteks Indonesia, keluarga menjadi sasaran utama program kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keluarga berperan sebagai konteks utama terbentuknya perilaku sehat, pola asuh, dukungan sosial, serta kepatuhan terhadap pengobatan dan pencegahan penyakit. Banyak masalah kesehatan prioritas—mulai dari kematian ibu-bayi, stunting, penyakit menular, hingga penyakit tidak menular—menuntut perubahan perilaku, penguatan ketahanan keluarga, dan kemampuan keluarga mengambil keputusan berbasis informasi. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan keluarga menjadi penting dalam layanan primer.

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2018), tenaga kesehatan masyarakat adalah profesional yang terlatih untuk melaksanakan berbagai intervensi kesehatan berbasis komunitas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Notoatmodjo, 2018). Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan kesehatan yang dihadapi keluarga di era modern, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga masalah kesehatan mental.

Pemberdayaan keluarga dalam bidang kesehatan merupakan proses yang memungkinkan keluarga untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka (Laverack, 2017). Konsep ini sejalan dengan paradigma kesehatan modern yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan mereka sendiri. Melalui pemberdayaan, keluarga tidak hanya menjadi objek intervensi

kesehatan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menentukan nasib kesehatan mereka.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif tentang peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga. Pembahasan akan mencakup konsep dasar tenaga kesehatan masyarakat, teori pemberdayaan keluarga, berbagai peran strategis yang dapat dilakukan, strategi implementasi yang efektif, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

B. Konsep Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Definisi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Tenaga kesehatan masyarakat (public health workforce) didefinisikan sebagai individu yang bekerja dalam sistem kesehatan untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan populasi (Ted & Elena, 2014). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014) .

Community Health Workers (CHWs) atau tenaga kesehatan berbasis masyarakat merupakan anggota komunitas yang dipercaya dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Mereka memfasilitasi akses anggota masyarakat terhadap layanan kesehatan dan dapat berperan sebagai perantara budaya antara anggota masyarakat dan penyedia layanan Kesehatan (Pantell et al., 2020). Kekuatan CHWs terletak pada kemampuan mereka untuk berhubungan dengan anggota masyarakat karena kesamaan pengalaman hidup, yang memungkinkan terbangunnya tingkat kepercayaan dan hubungan yang dapat mendorong respons yang jujur dari pasien

Menurut Schneider (2021), tenaga kesehatan masyarakat mencakup berbagai profesi yang bekerja dalam spektrum pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk epidemiolog, pendidik kesehatan, administrator kesehatan, perawat kesehatan masyarakat, sanitarian, dan berbagai profesi pendukung lainnya (Schneider, 2021). Karakteristik utama yang membedakan tenaga kesehatan masyarakat dengan tenaga kesehatan lainnya adalah fokus mereka pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di tingkat populasi, bukan hanya pengobatan individu.

2. Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat

Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice (2021) mengidentifikasi delapan domain kompetensi inti tenaga kesehatan masyarakat yang relevan dengan pemberdayaan keluarga (Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice, 2021):

- a. Analisis dan penilaian (assessment): kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan keluarga dan komunitas
- b. Pengembangan kebijakan dan perencanaan program: keterampilan merancang intervensi berbasis bukti untuk pemberdayaan keluarga
- c. Komunikasi: kemampuan berkomunikasi efektif dengan keluarga dari berbagai latar belakang
- d. Kompetensi budaya: sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan keluarga
- e. Dimensi komunitas dalam praktik: pemahaman tentang dinamika sosial yang mempengaruhi kesehatan keluarga
- f. Ilmu dasar kesehatan masyarakat: penguasaan teori dan prinsip kesehatan masyarakat
- g. Manajemen dan keuangan: kemampuan mengelola sumber daya untuk program pemberdayaan
- h. Kepemimpinan dan berpikir sistem: keterampilan memimpin perubahan dan memahami sistem kesehatan secara holistik

3. Jenis Tenaga Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Kementerian Kesehatan RI (2016) mengklasifikasikan tenaga kesehatan masyarakat menjadi beberapa kategori utama yaitu (1) tenaga kesehatan masyarakat profesional yang mencakup sarjana kesehatan masyarakat (SKM) dengan berbagai peminatan seperti epidemiologi, promosi kesehatan, administrasi kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan reproduksi; (2) tenaga kesehatan pendukung di komunitas yang mencakup kader kesehatan, bidan desa, perawat komunitas, dan sanitarian; (3) tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas yang meliputi dokter, perawat, bidan, nutrisisionis, dan tenaga promosi kesehatan; (4) pekerja sosial kesehatan yang berperan sebagai penghubung antara layanan kesehatan dengan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016, 2016).

C. Konsep Pemberdayaan Keluarga Dalam Kesehatan Masyarakat

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan (empowerment) dalam konteks promosi kesehatan didefinisikan oleh WHO sebagai proses di mana individu dan kelompok sosial memperoleh kendali yang lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka (World Health Organization (WHO), 2021). Pemberdayaan merupakan proses sosial, budaya, psikologis, atau politik yang memungkinkan individu mampu mengekspresikan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, menyusun strategi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan mencapai tindakan politik, sosial, serta budaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Keluarga sebagai unit sasaran pemberdayaan memiliki karakteristik unik. Menurut Michaelson et al. (2022) dan Ho et al. (2022), keluarga adalah kontributor penting bagi kondisi budaya yang mendukung kesehatan. Promosi kesehatan berbasis keluarga memiliki potensi besar karena anggota keluarga dapat saling mendukung dan memelihara satu sama lain sepanjang tahap kehidupan (Ho et al., 2022; Michaelson et al., 2021). Family-centered health promotion menekankan bahwa keluarga merupakan produsen utama kesehatan individu dan komunitas, sehingga harus menjadi fokus dalam kemitraan strategis dan program kesehatan masyarakat (Barnes et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan keluarga tercermin dalam berbagai program kesehatan seperti Posyandu Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Hadi et al. (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan strategi utama untuk mencapai kemandirian kesehatan masyarakat melalui pendekatan Community as Partners (CAP) yang mengintegrasikan upaya kesehatan berbasis komunitas dengan prinsip kolaborasi dan inovasi (Hadi et al., 2024).

Menurut Nutbeam dan Muscat (2021), pemberdayaan kesehatan keluarga mencakup tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah pemberdayaan individu yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri anggota keluarga dalam mengelola kesehatan. Dimensi kedua adalah pemberdayaan kolektif yang menekankan kemampuan keluarga untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kesehatan bersama. Dimensi ketiga adalah pemberdayaan struktural yang melibatkan perubahan kondisi sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan keluarga (Nutbeam & Muscat, 2021).

2. Landasan Teori Pemberdayaan Kesehatan

Teori pemberdayaan kesehatan berakar pada pemikiran Paulo Freire tentang pedagogi pembebasan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks

promosi kesehatan. Kaysin et al. (2024) mendefinisikan pemberdayaan sebagai cara di mana individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan terkait kesehatan dan pembangunan untuk memfasilitasi perubahan positif dalam kehidupan dan komunitas mereka. Pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan transformative (Kaysin et al., 2024).

Model teoritis yang banyak digunakan dalam pemberdayaan kesehatan keluarga meliputi Health Belief Model, Theory of Reasoned Action, dan Social Cognitive Theory. Ho et al. (2022) mengidentifikasi mekanisme tingkat keluarga dan individu yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan, termasuk self-empowerment dan self-regulation. Model parenting dimensions framework juga menjelaskan bagaimana persepsi anak terhadap responsivitas dan ketegasan orang tua mempengaruhi regulasi motivasional untuk perilaku sehat (Ho et al., 2022).

Teori sosial kognitif Bandura (2019) menyatakan bahwa efikasi diri (self-efficacy) merupakan determinan kunci dalam perubahan perilaku kesehatan. Keluarga yang memiliki efikasi diri tinggi lebih mampu mengadopsi dan mempertahankan perilaku kesehatan yang positif. Pemberdayaan berperan dalam meningkatkan efikasi diri melalui pengalaman keberhasilan, pembelajaran observasional, persuasi verbal, dan manajemen respons emosional (Bandura, 1991).

Model health belief (Rosenstock, 2015) menjelaskan bahwa perilaku kesehatan keluarga dipengaruhi oleh persepsi tentang kerentanan terhadap penyakit, keparahan penyakit, manfaat tindakan pencegahan, dan hambatan yang dirasakan. Pemberdayaan membantu keluarga mengembangkan persepsi yang akurat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi hambatan (Rosenstock, 1991). Piagam Ottawa (1986) menjadi landasan internasional yang menegaskan bahwa promosi kesehatan tidak hanya mencakup tindakan untuk memperkuat keterampilan dasar dan kapasitas individu, tetapi juga untuk mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan fisik yang berdampak pada kesehatan. Deklarasi Jakarta (1997) selanjutnya memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menekankan partisipasi komunitas sebagai kunci keberhasilan program kesehatan.

Berdasarkan sintesis literatur, Wallerstein et al. (2017) mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci pemberdayaan keluarga dalam kesehatan. Prinsip pertama adalah partisipasi aktif, di mana keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses kesehatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi intervensi. Prinsip kedua adalah penghormatan terhadap otonomi keluarga, yang mengakui hak keluarga untuk membuat keputusan tentang kesehatan mereka

sendiri. Prinsip ketiga adalah pendekatan berbasis kekuatan (strength-based approach), yang berfokus pada aset dan kapasitas yang dimiliki keluarga, bukan hanya pada defisit atau masalah. Prinsip keempat adalah keadilan sosial, yang mengakui bahwa ketidaksetaraan sosial mempengaruhi kesehatan dan pemberdayaan harus ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Prinsip kelima adalah keberlanjutan, di mana intervensi pemberdayaan harus dirancang untuk menghasilkan perubahan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Wallerstein, Duran, Oetzel, & Minkler, 2017).

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Keluarga

Pengukuran keberhasilan pemberdayaan keluarga memerlukan indikator yang komprehensif. Menurut Zimmerman (2022), indikator pemberdayaan keluarga dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkat. Pada tingkat individu, indikator meliputi peningkatan pengetahuan kesehatan, efikasi diri dalam mengelola kesehatan, kemampuan mengakses layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kesehatan. Pada tingkat keluarga, indikator mencakup peningkatan komunikasi tentang kesehatan antar anggota keluarga, pembagian tanggung jawab kesehatan yang seimbang, kemampuan mengatasi stres dan krisis kesehatan, serta dukungan sosial dalam keluarga. Pada tingkat komunitas, indikator meliputi partisipasi keluarga dalam kegiatan kesehatan komunitas, kontribusi keluarga dalam pemecahan masalah kesehatan bersama, dan pengaruh keluarga dalam kebijakan kesehatan lokal (Zimmerman, 2000).

D. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Keluarga

1. Peran sebagai Pendidik Kesehatan

Peran sebagai pendidik kesehatan merupakan fungsi fundamental tenaga kesehatan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga. Menurut Glanz et al. (2020), pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk memfasilitasi tindakan sukarela yang kondusif bagi kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pendidikan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik keluarga (Glanz et al., 2024).

Dalam menjalankan peran ini, tenaga kesehatan masyarakat menggunakan berbagai pendekatan pedagogi andragogi. Pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan pendekatan didaktik tradisional karena melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pembelajaran (Freire, 2008). Metode yang umum digunakan meliputi konseling kesehatan, demonstrasi, diskusi kelompok, penggunaan media edukasi, dan pembelajaran berbasis masalah.

Literasi kesehatan (health literacy) menjadi fokus utama dalam pendidikan kesehatan keluarga. Menurut Sørensen et al. (2019), literasi kesehatan mencakup kemampuan mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan keluarga melalui penyampaian informasi yang jelas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan konfirmasi pemahaman (Sørensen et al., 2015).

2. Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator menekankan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan keluarga untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri. Berbeda dengan peran pendidik yang lebih direktif, fasilitator berposisi sebagai mitra yang mendukung proses belajar dan pengembangan keluarga (Laverack, 2017). Tenaga kesehatan masyarakat sebagai fasilitator membantu keluarga mengidentifikasi masalah kesehatan, mengeksplorasi solusi potensial, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Keterampilan fasilitasi yang penting meliputi mendengar aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik konstruktif, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk diskusi. Tenaga kesehatan masyarakat juga berperan dalam memfasilitasi dialog antar anggota keluarga tentang isu-isu kesehatan, terutama dalam keluarga yang mengalami konflik atau komunikasi yang kurang efektif.

Dalam konteks pemberdayaan komunitas, tenaga kesehatan masyarakat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok pendukung keluarga (family support groups). Kelompok-kelompok ini menjadi wadah bagi keluarga untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan bersama-sama mencari solusi atas masalah kesehatan yang dihadapi (Wallerstein, Duran, Oetzel, & Minkle, 2017).

3. Peran sebagai Advokat

Advokasi merupakan peran penting tenaga kesehatan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan keluarga. Menurut Carlisle (2020), advokasi kesehatan melibatkan upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kebijakan yang meningkatkan Kesehatan (Carlisle, 2000). Tenaga kesehatan masyarakat mengadvokasi kepentingan keluarga di berbagai tingkat, mulai dari tingkat fasilitas kesehatan hingga tingkat kebijakan nasional.

Pada tingkat mikro, advokasi meliputi membantu keluarga mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, memperjuangkan hak-hak pasien, dan memastikan keluarga diperlakukan dengan bermartabat dalam sistem kesehatan. Pada tingkat meso, advokasi melibatkan pengaruh terhadap kebijakan dan

praktik organisasi kesehatan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga. Pada tingkat makro, advokasi mencakup partisipasi dalam proses kebijakan untuk mempengaruhi undang-undang dan regulasi yang berdampak pada kesehatan keluarga. Tenaga kesehatan masyarakat juga berperan dalam membangun kapasitas advokasi keluarga. Ini meliputi melatih anggota keluarga untuk menyuarakan kepentingan mereka, memahami hak-hak kesehatan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka (World Health Organization (WHO), 2003).

4. Peran sebagai Penghubung (Liaison)

Tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai penghubung antara keluarga dengan berbagai sumber daya dan layanan kesehatan. Menurut Rifkin (2009), peran ini penting karena sistem kesehatan sering kali kompleks dan sulit dinavigasi oleh keluarga, terutama keluarga dengan latar belakang pendidikan atau ekonomi yang terbatas. Tenaga kesehatan masyarakat membantu keluarga memahami sistem kesehatan, mengidentifikasi layanan yang relevan, dan mengakses layanan tersebut (Rifkin, 2009).

Peran penghubung juga mencakup koordinasi antara berbagai penyedia layanan kesehatan dan sosial. Tenaga kesehatan masyarakat bekerja sama dengan dokter, perawat, pekerja sosial, dan profesional lainnya untuk memastikan keluarga menerima perawatan yang terintegrasi dan komprehensif. Ini sangat penting untuk keluarga dengan kebutuhan kesehatan kompleks yang memerlukan berbagai jenis layanan (Goodwin, 2016).

Di Indonesia, peran penghubung dijalankan melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem rujukan antara fasilitas kesehatan, kerjasama lintas sektor (misalnya dengan dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat), dan jaringan kader kesehatan di tingkat komunitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014).

5. Peran sebagai Motivator

Motivasi merupakan faktor kunci dalam perubahan perilaku kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam memotivasi keluarga untuk mengadopsi dan mempertahankan perilaku kesehatan yang positif. Menurut Miller dan Rollnick (2023), wawancara motivasional (motivational interviewing) adalah pendekatan efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik keluarga untuk berubah (William & Rollnick, 2023). Dalam menjalankan peran ini, tenaga kesehatan masyarakat menggunakan berbagai teknik motivasi. Teknik tersebut meliputi pengakuan atas upaya dan pencapaian keluarga, penggunaan komunikasi yang empatik, eksplorasi ambivalensi terhadap perubahan,

penguatan kepercayaan diri, dan penghormatan terhadap otonomi keluarga dalam membuat keputusan.

Tenaga kesehatan masyarakat juga berperan dalam membantu keluarga mengatasi hambatan motivasi, seperti ketakutan, ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan, atau pengalaman negatif sebelumnya. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks sosial keluarga sangat penting dalam menjalankan peran motivator (Brownson et al., 2018)

6. Peran sebagai Penggerak Partisipasi

Partisipasi aktif keluarga merupakan esensi dari pemberdayaan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai penggerak partisipasi dengan menciptakan peluang dan mendorong keluarga untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kesehatan. Menurut Arnstein (dalam Cornwall, 2018), partisipasi dapat berkisar dari tingkat partisipasi yang manipulatif hingga kontrol penuh oleh warga (Cornwall, 2008). Tenaga kesehatan masyarakat mendorong partisipasi bermakna, di mana keluarga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Ini meliputi melibatkan keluarga dalam perencanaan program kesehatan, mengundang partisipasi dalam evaluasi layanan, dan menciptakan mekanisme umpan balik yang efektif. Di tingkat komunitas, partisipasi dapat mencakup keikutsertaan dalam forum kesehatan desa, kelompok kerja kesehatan, atau komite kesehatan sekolah (World Health Organization (WHO), 2021).

E. Strategi Pemberdayaan Keluarga Oleh Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Pendekatan Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah (home visit) merupakan strategi fundamental dalam pemberdayaan keluarga. Menurut Kitzman et al. (2019), program kunjungan rumah efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, dan meningkatkan kesiapan anak untuk sekolah. Kunjungan rumah memungkinkan tenaga kesehatan masyarakat untuk memahami konteks kehidupan keluarga secara langsung dan memberikan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga (Kitzman et al., 2019).

Elemen kunci keberhasilan program kunjungan rumah meliputi: (a) pelatihan yang memadai bagi pelaksana kunjungan; (b) standar operasional yang jelas; (c) frekuensi kunjungan yang memadai; (d) fokus pada membangun hubungan kepercayaan dengan keluarga; dan (e) penggunaan pendekatan berbasis kekuatan. Di Indonesia, kunjungan rumah dilaksanakan melalui berbagai

program, termasuk program bina keluarga balita, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, dan pemantauan pasien penyakit kronis (Oxford et al., 2018).

2. Pembentukan Kelompok Pendukung

Kelompok pendukung (support groups) merupakan wadah bagi keluarga dengan pengalaman atau tantangan serupa untuk saling berbagi, belajar, dan mendukung. Menurut Heisler (2012), kelompok pendukung efektif dalam meningkatkan kesehatan mental, manajemen penyakit kronis, dan pemulihan dari kecanduan. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok pendukung (Heisler, 2012). Langkah-langkah dalam pembentukan kelompok pendukung meliputi identifikasi kebutuhan, rekrutmen anggota potensial, pelatihan fasilitator kelompok, pengembangan struktur dan aturan kelompok, serta pendampingan awal hingga kelompok dapat berjalan mandiri. Contoh kelompok pendukung dalam kesehatan keluarga antara lain kelompok pendukung ASI, kelompok penderita diabetes, kelompok orang tua anak berkebutuhan khusus, dan kelompok pemulihan mental.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Era digital membuka peluang baru dalam pemberdayaan keluarga. Menurut Blandford et al. (2020), teknologi kesehatan digital (digital health technology) dapat meningkatkan akses informasi kesehatan, memfasilitasi komunikasi dengan penyedia layanan, dan mendukung manajemen kesehatan mandiri. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam memperkenalkan dan membimbing keluarga dalam memanfaatkan teknologi kesehatan digital (Blandford et al., 2020).

Aplikasi kesehatan mobile (mHealth) dapat membantu keluarga memantau kesehatan, mengingat jadwal pengobatan, mengakses informasi kesehatan, dan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Telemedicine memungkinkan keluarga di daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi kesehatan tanpa harus bepergian jauh. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kesehatan dan membangun komunitas dukungan online (WHO, 2021). Namun, pemanfaatan teknologi digital juga memunculkan tantangan terkait kesenjangan digital (digital divide), privasi data, dan risiko misinformasi. Tenaga kesehatan masyarakat perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam merancang strategi pemberdayaan berbasis teknologi (Lupton, 2017).

4. Metode Edukasi dan Komunikasi Kesehatan

Metode edukasi kesehatan untuk pemberdayaan keluarga meliputi berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sasaran. Metode penyuluhan langsung (face-to-face) tetap menjadi metode

utama dalam pemberdayaan keluarga karena memungkinkan interaksi yang lebih personal dan responsif. Edukasi yang diberikan sesuai dengan diagnosis, kondisi fisik, dan kebutuhan spesifik keluarga akan lebih efektif dibandingkan informasi yang bersifat umum (Rafieifar et al., 2025). Metode pengajaran tatap muka dan blended lebih efektif dalam menghasilkan akuisisi keterampilan dan lebih disukai oleh siswa dibandingkan dengan metode pengajaran sepenuhnya online (Forde et al., 2024).

Selain metode langsung, pemanfaatan media dan teknologi informasi semakin penting dalam era digital. Susanti et al. (2023) melaporkan penguatan kader dengan literasi digital dalam pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi iPosyandu yang dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Namun, perlu dipahami bahwa teknologi digital bukanlah pengganti edukasi langsung, melainkan pelengkap yang dapat memperkuat pesan kesehatan yang sudah disampaikan tenaga Kesehatan (Susanti et al., 2023).

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan berbagai metode untuk mencapai perubahan perilaku kesehatan. Peer education atau edukasi sebaya juga terbukti efektif dalam pemberdayaan keluarga karena pesan kesehatan disampaikan oleh sesama anggota komunitas yang memiliki pengalaman serupa. Pendekatan ini meningkatkan penerimaan dan kredibilitas informasi kesehatan.

5. Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas (community-based approach) mengakui bahwa keluarga tidak hidup dalam isolasi tetapi merupakan bagian dari komunitas yang lebih luas. Menurut Wallerstein et al. (2017), pemberdayaan keluarga akan lebih efektif jika didukung oleh pemberdayaan komunitas secara keseluruhan. Tenaga kesehatan masyarakat bekerja tidak hanya dengan keluarga individual tetapi juga dengan organisasi dan institusi komunitas (Wallerstein, Duran, Oetzel, & Minkler, 2017).

Strategi pemberdayaan berbasis komunitas meliputi pemetaan aset komunitas (community asset mapping), mobilisasi sumber daya lokal, penguatan organisasi berbasis komunitas, pengembangan koalisi kesehatan, dan advokasi kebijakan tingkat komunitas. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan melalui program desa siaga, posyandu, dan forum kesehatan desa (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, 2013).

6. Pendekatan Siklus Kehidupan

Pendekatan siklus kehidupan (life course approach) mengakui bahwa kebutuhan kesehatan keluarga berubah seiring dengan tahap perkembangan keluarga. Menurut Halfon et al. (2018), intervensi kesehatan harus disesuaikan

dengan tahap siklus kehidupan, dari kehamilan dan kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Tenaga kesehatan masyarakat merancang strategi pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap tahap.

Pada tahap kehamilan dan kelahiran, fokus pemberdayaan adalah pada persiapan persalinan, perawatan bayi, dan pemberian ASI eksklusif. Pada masa kanak-kanak, pemberdayaan mencakup stimulasi tumbuh kembang, imunisasi, dan gizi. Pada masa remaja, fokus meliputi kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, dan kesehatan mental. Pada masa dewasa, pemberdayaan meliputi pencegahan penyakit tidak menular dan manajemen stres. Pada masa lansia, fokus adalah pada menjaga kemandirian dan kualitas hidup.

F. Strategi Penguatan Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat

1. Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Masyarakat

Penguatan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga. Strategi penguatan meliputi pelatihan berbasis kompetensi yang mencakup 25 kecakapan dasar kader bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Panduan Keterampilan Dasar Kader Bidang Kesehatan (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023). Pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis diperlukan untuk memastikan kader dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik sehari-hari (Siregar et al., 2023).

Kaysin et al. (2024) menekankan enam tema utama dalam program pelatihan berbasis pemberdayaan, yaitu: seleksi, pelatihan dasar, pendidikan dan dukungan berkelanjutan, partisipasi komunitas, pemberdayaan komunitas, serta komitmen dan keberlangsungan. Pendekatan ini telah terbukti berhasil dalam membangun kapasitas tenaga kesehatan masyarakat yang mampu memberdayakan keluarga secara berkelanjutan (Kaysin et al., 2024).

2. Integrasi Layanan dan Koordinasi Lintas Sektor

Pemberdayaan keluarga yang efektif memerlukan integrasi layanan dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Pendekatan Co-production merupakan strategi yang direkomendasikan untuk memaksimalkan pendayagunaan posyandu dalam program integrasi layanan primer. Koordinasi antara puskesmas, posyandu, PKK, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada keluarga (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023).

PAHO (2024) menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk kesehatan yang mencakup aksi lintas sektor, partisipasi sosial, dan kesetaraan. Kebijakan dari sektor pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, perumahan,

transportasi, dan perencanaan perkotaan memiliki dampak terhadap kesehatan sehingga perlu dipertimbangkan dalam strategi pemberdayaan keluarga yang holistik. Implikasinya untuk strategi pemberdayaan keluarga yang holistik (Afriansyah et al, 2023):

- a. Koordinasi lintas sektor: program keluarga tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi disinergikan dengan sekolah, dunia kerja, layanan sosial, dan tata kota (mis. akses aman ke sekolah/puskesmas, hunian layak, pekerjaan layak).
- b. Partisipasi sosial bermakna: keluarga/komunitas dilibatkan dalam identifikasi masalah, perencanaan, dan evaluasi agar intervensi sesuai kebutuhan lokal
- c. Lensa kesetaraan: prioritas pada keluarga yang paling rentan (kemiskinan, disabilitas, wilayah terpencil) melalui kebijakan yang mengurangi hambatan akses dan ketimpangan

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan membuka peluang untuk memperkuat pemberdayaan keluarga. Aplikasi iPosyandu dan platform digital lainnya dapat mendukung pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kesehatan keluarga secara real-time. Tenaga kesehatan masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam tugas pemberdayaan keluarga.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kemajuan digital bukanlah pengganti interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan keluarga. Teknologi digital harus diposisikan sebagai pelengkap yang dapat memperkuat pesan kesehatan dan memperluas jangkauan layanan. Keseimbangan antara pendekatan digital dan tatap muka perlu dijaga untuk memastikan efektivitas pemberdayaan keluarga di berbagai konteks.

4. Penguatan Sistem Insentif dan Pengakuan

Sistem insentif yang adekuat diperlukan untuk mempertahankan motivasi dan komitmen tenaga kesehatan masyarakat, khususnya kader yang bekerja secara sukarela. Kajian tentang insentif non-finansial untuk kader kesehatan sukarelawan menunjukkan pentingnya pengakuan, apresiasi, dan dukungan dari sistem kesehatan dan komunitas (Haile et al., 2018). Pemerintah perlu mengembangkan skema insentif yang berkelanjutan dan sistem pengakuan yang dapat meningkatkan motivasi kader dalam memberdayakan keluarga.

G. Tantangan Dan Solusi Tenaga Kesehatan Dalam Pemberdayaan Keluarga

1. Tantangan yang Dihadapi

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi tenaga kesehatan adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga. Hasil penelitian Reskiaddin et al. (2020) di Yogyakarta menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat di daerah semi-perkotaan meliputi kurangnya pengalaman, keterampilan, pengetahuan, serta konsep diri kader kesehatan yang belum memadai (Reskiaddin et al., 2020). Pelatihan yang tidak memadai muncul sebagai isu signifikan di berbagai negara di Asia. Bukti menunjukkan bahwa pelatihan suportif berkelanjutan untuk Community Health Workers (CHWs) secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam melayani komunitas, meningkatkan produktivitas profesional, dan meningkatkan kepuasan kerja.

Fitryasari et al. (2025) dalam penelitiannya di Indonesia menemukan bahwa tantangan yang dihadapi petugas kesehatan komunitas dalam memberikan layanan kesehatan mental di masyarakat meliputi keterbatasan pemahaman tentang gangguan kesehatan mental. Keluarga pasien sering kali memiliki stigma dan pemahaman yang terbatas tentang kondisi kesehatan, yang menambah kompleksitas tugas CHWs dalam melakukan edukasi dan pemberdayaan (Fitryasari et al., 2025).

b. Beban Kerja Berlebihan dan Perluasan Peran

Beban kerja CHWs merupakan sumber utama stres dan kecemasan karena mereka harus menyeimbangkan agenda pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan intervensi dengan kebutuhan mereka sendiri untuk menghidupi keluarga, terutama bagi mereka yang tidak dibayar. Proliferasi peran merupakan ancaman lain terhadap retensi pengetahuan dan keterampilan. Peran tambahan yang diberikan secara formal maupun informal kepada CHWs oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah menghalangi mereka dari mencapai kemahiran dalam peran yang sebelumnya ditugaskan (Musoke et al., 2022).

Salve et al. (2023) mengkonfirmasi tantangan dengan peran CHW yang terus berkembang. Mereka sering kali menjadi saluran melalui mana semua program disampaikan di tingkat komunitas, yang mengharuskan mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, serta mengatasi beban kerja yang meningkat. Hal ini berdampak pada kemampuan dan kemauan CHW untuk memberikan layanan, serta meningkatkan ketakutan akan infeksi bagi diri mereka sendiri maupun keluarga mereka (Salve et al., 2023).

c. Hambatan Budaya, Gender, dan Dinamika Keluarga

Isu gender merupakan hambatan bagi pekerjaan CHWs, terutama dengan anggota masyarakat dari jenis kelamin yang berbeda seputar isu kesehatan sensitif. Ketidaksetaraan gender dalam tenaga kerja layanan kesehatan berarti bahwa pekerja laki-laki dan perempuan memiliki akses yang tidak setara terhadap peluang kerja dan kemajuan karir (Musoke et al., 2022). Sifat patriarkal dari banyak budaya di mana CHWs bekerja berarti bahwa laki-laki sering menganggap diri mereka sebagai penjaga komunitas tempat mereka tinggal. Di beberapa lingkungan, CHWs sering harus meminta persetujuan laki-laki sebelum mereka diizinkan berbicara dengan anggota rumah tangga perempuan. Dalam banyak kesempatan, CHWs telah menempuh jarak jauh, hanya untuk ditolak izinnya oleh kepala rumah tangga laki-laki untuk berbicara dengan keluarga untuk promosi kesehatan termasuk mendiskusikan isu kesehatan sensitive. Banyak CHWs perempuan mengalami rasa malu di depan keluarga karena mencoba berbicara dengan laki-laki tentang berbagai isu kesehatan yang mempengaruhi mereka, seperti reproduksi.

d. Stigma Sosial dan Miskonsepsi Masyarakat

Stigma keluarga dan pemahaman yang terbatas tentang gangguan kesehatan merupakan tema tantangan yang signifikan bagi CHWs (Fitryasari et al., 2025). Salve et al. (2023) mengidentifikasi bahwa anggota keluarga dan komunitas dapat mengucilkan CHWs karena ketakutan akan infeksi atau miskonsepsi tentang peran CHWs. Hal ini menunjukkan perlunya pesan yang jelas tentang peran CHWs dan strategi untuk mengatasi stigma. Kecurigaan dari pasangan merupakan salah satu sumber utama kekerasan dalam rumah tangga di banyak komunitas. Dalam banyak kesempatan, CHWs mendapati diri mereka sebagai korban ketidakpercayaan domestik saat menjalankan tugas mereka di komunitas (Salve et al., 2023).

e. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Olaniran et al. (2022) menemukan bahwa di seluruh negara yang diteliti, CHWs dihadapkan pada dukungan infrastruktur yang tidak memadai, yang secara negatif mempengaruhi penyampaian layanan dan cakupan. Kondisi kerja yang sulit dan status kepegawaian yang lemah merupakan pengalaman banyak CHWs selama waktu rutin. Kompensasi yang tidak memadai secara konsisten disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan pekerja perawatan langsung meninggalkan sektor perawatan jangka panjang untuk pekerjaan lain (Olaniran et al., 2022).

Di Indonesia, menurut Kementerian Koordinator Bidang PMK (2023), terdapat ketimpangan pemenuhan SDM kesehatan yang mengkhawatirkan. Sekitar 50

persen puskesmas di Indonesia Timur seperti Papua tidak memiliki dokter umum, dan kondisi lebih mengkhawatirkan untuk dokter spesialis. Keterbatasan ini berpengaruh pada ketidaksetaraan pemberian layanan dan penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Hambatan geografis juga menimbulkan dampak signifikan terhadap akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil (Cahya et al., 2023).

2. Solusi Strategis untuk Mengatasi Tantangan

a. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Berkelanjutan

Peningkatan keterampilan dan pemberdayaan CHWs membantu meningkatkan kesehatan mental komunitas (Fitryasari et al., 2025). Tiga tema mengenai upaya mengatasi tantangan yang diidentifikasi meliputi: mempertahankan motivasi diri, memupuk efikasi diri, dan menggunakan keterampilan komunikasi saat mendekati keluarga dan pasien. Investasi dalam pengembangan kapasitas CHWs tidak hanya memberdayakan mereka tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan dengan menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten (MHP Salud, 2020).

Ketika CHWs menerima pelatihan yang memadai dalam bidang-bidang seperti pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, dan keterlibatan komunitas, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif. Hal ini menghasilkan peningkatan kepercayaan komunitas terhadap layanan kesehatan dan partisipasi yang lebih besar dalam program kesehatan. Panda et al. (2024) menunjukkan bahwa model telementoring ECHO terbukti efektif untuk pengembangan kapasitas petugas kesehatan komunitas di India (Panda et al., 2024).

b. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Telemedicine

Penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan informasi yang jelas, objektif, andal, dan mudah diakses merupakan tindakan strategis untuk mempromosikan literasi kesehatan dan mengakomodasi kebutuhan perawatan yang bervariasi dari caregiver informal (Soares et al., 2024). Teknologi kesehatan digital telah mengubah kedokteran sosial dan kesehatan komunitas dengan memungkinkan penyedia layanan kesehatan terhubung dengan pasien dan komunitas dengan cara-cara baru. Platform telemedicine pemerintah India, e-Sanjeevani, telah menawarkan lebih dari 10 juta telekonsultasi di daerah-daerah yang kurang terlayani, meningkatkan akses kesehatan bagi penduduk terpencil (Rana et al., 2024).

Alat kesehatan digital, telemedicine, dan aplikasi kesehatan mobile sangat penting untuk menciptakan lanskap kesehatan yang lebih adil yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk merawat berbagai populasi

pasien di seluruh negeri. Dengan bekerja sama dengan caregiver informal dalam pengembangan teknologi baru, para peneliti membangun alat baru yang memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan pusat kesehatan komunitas dapat menjadi solusi dengan mendekatkan layanan medis ke masyarakat, sementara pemanfaatan layanan telemedicine dapat mengatasi hambatan jarak dan memperluas cakupan layanan (eHealth, 2024).

c. Penguatan Dukungan Sistem Kesehatan

Salve et al. (2023) mengidentifikasi bahwa hambatan dan fasilitator implementasi dapat menawarkan implikasi kebijakan dan praktik yang penting untuk cara terbaik mendukung program CHW. Temuan menunjukkan pentingnya penekanan pada hubungan dalam model CHW, serta desain program yang terstruktur dan berpusat pada pasien. Dukungan dari sistem kesehatan, rekan kerja, komunitas, dan keluarga diberikan kepada CHWs saat mereka mengambil tanggung jawab baru dan melanjutkan tugas-tugas yang ada. Tindakan yang diambil untuk mendukung CHWs harus mengatasi masalah sistemik yang mempengaruhi CHWs, melampaui langkah-langkah jangka pendek untuk mendukung ketahanan sistem kesehatan yang lebih kuat dan kesejahteraan CHWs yang berkelanjutan (Salve et al., 2023).

Untuk mengatasi hambatan administratif, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kapasitas serta pelatihan tenaga medis, dan penerapan sistem teknologi informasi yang lebih efisien (Gunawan et al., 2024). Dengan perbaikan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat lebih mudah, pelayanan menjadi lebih efektif, serta kualitas layanan di puskesmas meningkat.

d. Pendekatan Berbasis Budaya Lokal dan Sensitivitas Gender

Untuk membantu mengatasi tantangan budaya dan gender, diperlukan perhatian yang lebih besar untuk memahami tantangan di tingkat individu dan komunitas. Kita bisa memulai dengan bertanya ancaman pribadi apa yang mungkin dialami CHWs dalam budaya berbeda yang praktiknya bertentangan dengan pesan komunikasi kesehatan yang mereka coba sampaikan (Musoke et al., 2022). Penting untuk mengeksplorasi bagaimana CHWs dapat didukung dalam memberikan promosi kesehatan dan edukasi kepada komunitas yang beragam dengan keyakinan budaya dan agama yang berbeda.

Suara-suara CHWs harus didengarkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan tindakan yang tepat diambil. Hal ini penting karena rasa aman dan percaya diri merupakan hal sentral bagi CHWs dalam mewujudkan tujuan mereka saat bekerja dengan komunitas. Solusi untuk tantangan-tantangan ini perlu diproduksi bersama dengan CHWs untuk memperkuat hubungan mereka

dengan komunitas yang mereka layani dan membentuk intervensi yang lebih berkelanjutan untuk penyampaian layanan kesehatan.

e. Model Pemberdayaan Keluarga yang Terstruktur

Model pemberdayaan berpusat keluarga (Family-Centered Empowerment Model) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis. Penelitian menunjukkan bahwa setelah intervensi pemberdayaan berpusat keluarga, kualitas hidup pada kelompok intervensi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perawat dapat secara efektif melibatkan pasien dengan penyakit kronis, khususnya hipertensi, dan keluarga mereka dalam proses pengobatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Luthfa et al., 2025). Teori pemberdayaan harus menjadi komponen program promosi kesehatan. Grafft et al. (2024) mengidentifikasi lima tema yang sesuai dengan proses dimana orang tua memperoleh pemberdayaan: pembentukan persahabatan dan penguatan hubungan, penguatan hubungan dengan anak dan keyakinan pada kemampuan mengasuh yang berhasil, pengalaman pengetahuan yang mengarah pada perubahan perilaku, penggunaan sumber daya baru untuk meningkatkan kesehatan keluarga, dan pengambilan tindakan (Grafft et al., 2024).

H. Kesimpulan

Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga. Berbagai peran yang dijalankan meliputi pendidik kesehatan, fasilitator, advokat, penghubung, motivator, dan penggerak partisipasi. Peran-peran ini saling melengkapi dan bersinergi dalam upaya meningkatkan kapasitas keluarga untuk mengelola kesehatan mereka secara mandiri.

Strategi pemberdayaan keluarga yang efektif meliputi kunjungan rumah, pembentukan kelompok pendukung, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan berbasis komunitas, dan pendekatan siklus kehidupan. Pemilihan dan kombinasi strategi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan keluarga serta konteks lokal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural, sosial budaya, dan kapasitas, pemberdayaan keluarga dapat berhasil dengan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, pendekatan yang komprehensif dan sensitif konteks, serta pembelajaran berkelanjutan dari praktik. Investasi dalam pemberdayaan keluarga adalah investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan bangsa di masa depan.

I. Referensi

- Afriansyah et al. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 248–287. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L)
- Barnes, M. D., Hanson, C. L., Novilla, L. B., Magnusson, B. M., Crandall, A. A. C., & Bradford, G. (2020). Family-Centered Health Promotion: Perspectives for Engaging Families and Achieving Better Health Outcomes. *Inquiry (United States)*, 57, 0–5. <https://doi.org/10.1177/0046958020923537>
- Blandford, A., Wesson, J., Amalberti, R., AlHazme, R., & Allwihan, R. (2020). Opportunities and challenges for telehealth within, and beyond, a pandemic. *The Lancet Global Health*, 8(11), e1364–e1365. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30362-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30362-4)
- Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Green, L. W. (2018). Building Capacity for Evidence-Based Public Health: Reconciling the Pulls of Practice and the Push of Research. *Annual Review of Public Health*, 39, 27–53. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-014746>
- Cahya, R., Sulistiadi, W., Tu, N. F., & Haryo, P. (2023). Dampak Hambatan Geografis dan Strategi Akses Pelayanan Kesehatan : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(5), 868–877.
- Carlisle, S. (2000). Health Promotion, Advocacy and Health Inequalities: a Conceptual Framework. *HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL*, 15(4). <https://doi.org/10.4135/9781446251003>
- Cornwall, A. (2008). Unpacking “Participation” Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice. (2021). *Core Competencies for Public Health Professionals* (Issue October).
- Dhingra, D., & Dabas, A. (2020). Global Strategy on Digital Health. In *Indian Pediatrics* (Vol. 57, Issue 4). <https://doi.org/10.1007/s13312-020-1789-7>
- Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (2023). *Kurikulum Pelatihan Bagi Pelatih Keterampilan Dasar Bagi Posyandu*. Kementerian

Kesehatan RI (Kemenkes RI).

- Fitryasari, R., Marthoenis, M., Warsini, S., Usher, K., Nihayati, H. E., Kusumawardani, W., & Sari, H. (2025). Examining the challenges encountered by community health workers and empowering them to address mental health disorders: A qualitative study in Indonesia. *International Journal of Nursing Sciences*, 12(1), 27–34. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2024.12.003>
- Forde, C., O'Brien, A., Croitoru, O., Molloy, N., Amisano, C., Brennan, I., & McInerney, A. (2024). Comparing Face-to-Face, Blended and Online Teaching Approaches for Practical Skill Acquisition: A Randomised Controlled Trial. *Medical Science Educator*, 34(3), 627–637. <https://doi.org/10.1007/s40670-024-02026-8>
- Freire, P. (2008). *Pedagogy of the Oppressed*, trans. Myra Bergman Ramos. In *Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy*.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2024). *Health behavior: Theory, research, and practice* (6th editio). Jossey-Bass.
- Goodwin, N. (2016). Understanding Integrated Care. *International Journal of Integrated Care*, 16(4), 1–4. <https://doi.org/10.5334/ijic.2530>
- Grafft, N., Gago, C., Garcia, E., Aftosmes-Tobio, A., Jurkowski, J. M., Blaine, R. E., & Davison, K. K. (2024). Parent Experiences of Empowerment: Understanding the Role of Parent Empowerment in Child Health Promotion. *Family and Community Health*, 47(4), 261–274. <https://doi.org/10.1097/FCH.0000000000000412>
- Gunawan, A. N., Hanifa, N. I., Khathimah, H., Hanafi, R. A., Farahany, S., Putri, Y. W., Saragih, T. R., Syah Putra, A. A., & Agustina, D. (2024). Analisis Hambatan Administrasi Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Desa Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 6502–6510. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.36485>
- Hadi, I., Idris, B. N. A., Halid, S., & Supriyadi, Z. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu Keluarga Berbasis Community as Partners Untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 6(4). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Heisler, M. (2012). Different Models to Mobilize Peer Support to Improve Diabetes Self-Management and Clinical Outcomes: Evidence, Logistics, Evaluation Considerations and Needs For Future Research. *Fam Practicse*, 29(4).

- Ho, Y. C. L., Mahirah, D., Ho, C. Z. H., & Thumboo, J. (2022). The role of the family in health promotion: a scoping review of models and mechanisms. *Health Promotion International*, 37(6), 1–14. <https://doi.org/10.1093/heapro/daac119>
- Kaysin, A., Antoniello, P., Agarwal, S., & Perry, H. (2024). Strategies for Sustained Empowerment of Community Health Workers: A Qualitative Analysis of the Comprehensive Rural Health Project in Jamkhed, India. *Inquiry (United States)*, 61. <https://doi.org/10.1177/00469580241235059>
- Kitzman, H., Olds, D. L., Knudtson, M. D., Cole, R., Anson, E., Smith, J. A., Fishbein, D., DiClemente, R., Wingood, G., Caliendo, A. M., Hopfer, C., Miller, T., & Conti, G. (2019). Prenatal and infancy nurse home visiting and 18-year outcomes of a randomized trial. *Pediatrics*, 144(6), 82–94. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-3876>
- Laverack, G. (2017). *Health Promotion in Disease Outbreaks and Health Emergencies*. CRC Press.
- Lupton, D. (2017). *Digital Health Critical and Cross-Disciplinary Perspectives*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315648835>
- Luthfa, I., Yusuf, A., Fitryasari, R., & Khasanah, N. N. (2025). The effectiveness of the family-centered empowerment model towards the quality of life of older adults with hypertension. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 13(1). <https://doi.org/10.4081/hls.2024.13001>
- MHP Salud. (2020). *Sample Grant Proposal for a Community Health Worker Program Table of Contents*.
- Michaelson, V., Pilato, K. A., & Davison, C. M. (2021). Familyasa Health Promotion Setting: Ascoping Review of Conceptual Models of the Health-Promoting Family. *PLoS ONE*, April(12).
- Musoke, D., Nyashanu, M., Bugembe, H., Lubega, G. B., O'Donovan, J., Halage, A. A., & Gibson, L. (2022). Contested notions of challenges affecting Community Health Workers in low- and middle-income countries informed by the Silences Framework. *Human Resources for Health*, 20(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00701-0>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Nutbeam, D., & Muscat, D. M. (2021). Health Promotion Glossary 2021. *Health*

Promotion International, 36(6).

- Olaniran, A., Banke-thomas, A., & Bar-zeev, S. (2022). *Not knowing enough , not having enough , not feeling wanted : Challenges of community health workers providing maternal and newborn services in Africa and Asia*. 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274110>
- Oxford, M. L., Spieker, S. J., Lohr, M. J., Fleming, C. B., Dillon, C., & Rees, J. (2018). Ensuring Implementation Fidelity of a 10-week Home Visiting Program in Two Randomized Clinical Trials. *Matern Child Health J.*, 22(3), 376–383. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.03.013.Mechanical>
- Panda, R., Lahoti, S., Mishra, N., Prabhu, R. R., Singh, K., Rai, A. K., & Rai, K. (2024). A mixed methods evaluation of the impact of ECHO® telementoring model for capacity building of community health workers in India. *Human Resources for Health*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12960-024-00907-y>
- Pantell, M., Hessler, D., Long, D., Alqassari, M., Schudel, C., Laves, E., Velazquez, D. E., Amaya, A., Sweeney, P., Burns, A., Harrison, F. L., Adler, N. E., & Gottlieb, L. M. (2020). Effects of In-Person Navigation to Address Family Social Needs on Child Health Care Utilization. *Jama Network*, Jun 1(3 (6)).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016, 39 Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) (2016).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, 65 Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) (2013). https://www.researchgate.net/profile/Vivi_Setiawaty/publication/327385648_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_Penyakit_Demam_Kuning/links/5d66190992851c619d7b7aec/Pedoman-Pencegahan-dan-Pengendalian-Penyakit-Demam-Kuning.pdf?origin=publication_detail%0Aht
- Rafieifar, M., Hanbidge, A. S., Lorenzini, S. B., & Macgowan, M. J. (2025). Comparative Efficacy of Online vs. Face-to-Face Group Interventions: A Systematic Review. *Research on Social Work Practice*, 35(5), 524–542. <https://doi.org/10.1177/10497315241236966>
- Rana, R. K., Kapoor, N., Kumar, D., Verma, M., & Taneja, G. (2024). Digital Health Revolution in India: Transforming Health and Medicine. *Indian Journal of Community Medicine*, 49(8), S205–S209. <https://doi.org/10.4103/ijcm.IJCM>
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar2, V., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit

Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(2), 43–49. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>

Rifkin, S. B. (2009). Lessons from community participation in health programmes: a review of the post Alma-Ata experience. *International Health*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.1016/j.inhe.2009.02.001>

Rosenstock, I. M. (1991). The Health Belief Model: Explaining Health Behavior Through Expectancies. *Health Behavior and Health Education*.

Salve, S., Raven, J., Das, P., Srinivasan, S., Khaled, A., Hayee, M., Olisenekwu, G., & Gooding, K. (2023). Community health workers and Covid-19: Cross-country evidence on their roles, experiences, challenges and adaptive strategies. *PLOS Global Public Health*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001447>

Schneider, M.-J. (2021). *Introduction to Public Health* (Sixt Editi). Jones & Barlett Learning.

Siregar, N. Y., Hakim, F., & Ramadhan, K. (2023). Knowledge and Role of Cadres in Early Detection Stunting in Toddlers. *Napande: Jurnal Bidan*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.33860/njb.v2i2.2808>

Soares, S., Hoffmeister, L. V., de Fátima Fernandes, M., Henriques, A., & Costa, A. (2024). The Use of Digital Technologies in the Promotion of Health Literacy and Empowerment of Informal Caregivers: Scoping Review. *JMIR Aging*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.2196/54913>

Sørensen, K., Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., Fullam, J., Kondilis, B., Agraftotis, D., Ueters, E., Falcon, M., Mensing, M., Tchamov, K., Van Den Broucke, S., & Helmut Brand. (2015). Health literacy in Europe: Comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). *European Journal of Public Health*, 25(6), 1053–1058. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043>

Susanti, A. I., Nuraini, A., Ferdian, D., Nurparidah, R., Jayanti, E. D., Kedokteran, F., Padjadjaran, U., Kedokteran, F., Padjadjaran, U., & Tangerang, K. (2023). *Penguatan Kader dengan Literasi Digital dalam Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Aplikasi iPosyandu Media Karya Kesehatan : Volume 6 No 2 November 2023 Pendahuluan Salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yaitu dengan*. 6(2), 284–299.

Ted, T., & Elena, V. (2014). *The New Public Health* (Third Edit, Vol. 6). Academic Press.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014).
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J. G., & Minkler, M. (2017). *Community-Based Participatory Research for Health: Advancing Social and Health Equity* (3rd edition (ed.)). Jossey-Bass.
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J. G., & Minkler, M. (2017). *Community-Based Participatory Research for Health: Advancing Social and Health Equity*. Jossey-Bass.
- William, M., & Rollnick, S. (2023). *Motivational Interviewing: Helping People Change and Grow (Applications of Motivational Interviewing Series)*. The Guilford Press.
- World Health Organization (WHO). (2003). *Global Strategy for Infant and Young Children*.
- World Health Organization (WHO). (2021). Health Promotion Glossary of Terms 2021. In *World Health Organization*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349>
- Zimmerman, M. (2000). *Empowerment Theory*. Kluwer Academic Publishers. *ology* (pp. 43-63). Springer.

J. Glosarium

Advokasi kesehatan: Upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan, program, atau keputusan agar mendukung peningkatan kesehatan keluarga/komunitas.

Brainstorming/diskusi kelompok: Metode edukasi yang melibatkan pertukaran ide dan pengalaman secara interaktif antar peserta.

CAP (Community as Partners): Pendekatan kesehatan masyarakat yang memandang komunitas sebagai mitra aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan menjalankan solusi kesehatan.

Digital health technology (teknologi kesehatan digital): Pemanfaatan teknologi (aplikasi, platform, perangkat) untuk edukasi, pemantauan, komunikasi, dan layanan kesehatan.

Efikasi diri (self-efficacy): Keyakinan individu/keluarga bahwa mereka mampu melakukan tindakan kesehatan dan mempertahankan perilaku sehat.

CHAPTER 6

KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA TENAGA KESEHATAN, PASIEN DAN KELUARGA

Nur Aini fatimah, S.Kom., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelayanan kesehatan. Interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi medis, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta mendukung proses penyembuhan secara holistik. Dalam praktik pelayanan kesehatan, seringkali ditemukan berbagai hambatan komunikasi, seperti perbedaan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, kondisi emosional pasien, hingga keterbatasan waktu tenaga kesehatan. Hambatan-hambatan ini dapat berdampak pada kesalahpahaman, penurunan kualitas pelayanan, dan bahkan kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan keterampilan komunikasi yang efektif agar hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga dapat terjalin secara harmonis.

Melakukan komunikasi yang efektif di Rumah sakit maupun masyarakat sangat penting menentukan suksesnya pelaksanaan program kesehatan. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan pada pasien dilakukan oleh tim kesehatan antara lain staf medis (dokter umum maupun spesialis), Perawat, Bidan, Nutrisi dan farmasi, analis laboratorium, penata rontgen, dan fisioterapis (Tribunnews.com, 2018). Tim kesehatan ini memerlukan perencanaan dan koordinasi tingkat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasien yang unik. Pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit merupakan implementasi pelayanan yang multidisiplin dan komprehensif dari beberapa bidang keilmuan (Susilaningih, 2016). Upaya peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan koordinasi yang dinamis antar berbagai klinisi dan interdisiplin untuk membangun tim pelayanan dengan tatanan dan kultur pendekatan interdisiplin atau interprofesional. Pasien yang ditangani secara interdisiplin dapat meningkatkan kesinambungan asuhan keperawatan, kepuasan pasien dan mengurangi dampak hospitalisasi serta angka kematian (Mitchell&Crittenden,2000). Kolaborasi interprofesional merupakan strategi untuk mencapai kualitas hasil asuhan yang diinginkan secara efektif dan efisien dalam

pelayanan kesehatan. Komunikasi dalam kolaborasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien (Reni, A al,2010).

Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatannya (World Medical Association, 2018). Keluarga berperan sebagai pendukung utama pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis (Sudore et al., 2017). Oleh karena itu, komunikasi harus melibatkan pasien dan keluarga secara aktif (WHO, 2017). Tenaga kesehatan sering menghadapi tantangan komunikasi akibat perbedaan latar belakang budaya dan tingkat pendidikan pasien (Betancourt et al., 2016). Kemampuan komunikasi interpersonal menjadi kompetensi inti bagi profesi kesehatan (Hargie, 2011). Pelatihan komunikasi terbukti meningkatkan kepuasan pasien dan hasil klinis (Silverman et al., 2013).

Komunikasi verbal dan nonverbal memiliki peran yang sama penting dalam interaksi klinis (Knapp et al., 2014). Bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara memengaruhi persepsi pasien terhadap empati tenaga kesehatan (Hall et al., 2015). Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan kejadian tidak diinginkan dalam pelayanan kesehatan (Joint Commission, 2016).

Pendekatan komunikasi berpusat pada pasien menekankan pada penghargaan terhadap nilai dan preferensi pasien (Institute of Medicine, 2001). Model ini mendorong keterlibatan aktif pasien dalam perawatan kesehatannya (Epstein & Street, 2011). Keterlibatan keluarga memperkuat dukungan emosional bagi pasien (Laidsaar-Powell et al., 2018). Komunikasi efektif juga berperan dalam pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan pasien (Elwyn et al., 2012). Keputusan bersama meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapi (Stacey et al., 2017). Keluarga sering menjadi mediator dalam proses komunikasi klinis (Kemenkes RI, 2020). Hambatan komunikasi dapat berasal dari keterbatasan waktu dan beban kerja tenaga kesehatan (O'Daniel & Rosenstein, 2008). Lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka sangat diperlukan (WHO, 2017). Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi (Buntin et al., 2011).

Secara umum, komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh komunikator atau pengirim pesan, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh komunikan. Komunikasi efektif sangat penting dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, keluarga, pendidikan, dan hubungan interpersonal. Tanpa komunikasi yang efektif, kesalahpahaman bisa terjadi, konflik dapat muncul, dan tujuan yang ingin dicapai bersama sulit terwujud. Dalam konteks bisnis, komunikasi efektif dapat meningkatkan produktivitas, membangun hubungan baik dengan kolega, dan mempercepat pengambilan keputusan.

B. Tujuan dari Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan yang tidak hanya berfokus pada pengiriman informasi, tetapi juga pada tercapainya pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks profesional, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, komunikasi efektif menjadi fondasi utama dalam membangun interaksi yang bermakna dan berorientasi pada tujuan.

1. Mencapai Kesamaan Makna antara Pengirim dan Penerima Pesan

Tujuan utama komunikasi efektif adalah tercapainya kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Kesamaan makna ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pengirim. Tanpa kesamaan makna, komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif terhadap hubungan interpersonal maupun hasil suatu kegiatan profesional.

2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Penerima

Komunikasi efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penerima pesan. Melalui penyampaian informasi yang sistematis, jelas, dan terstruktur, penerima diharapkan mampu memperoleh wawasan baru serta memperdalam pemahamannya terhadap suatu topik. Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan pemahaman ini sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran, perawatan, dan pengambilan keputusan.

3. Mempengaruhi Sikap, Pendapat, dan Perilaku

Tujuan komunikasi efektif selanjutnya adalah memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku penerima pesan. Komunikasi yang disampaikan secara persuasif dan berbasis fakta dapat mendorong perubahan sikap serta membentuk perilaku yang diharapkan. Dalam praktik profesional, kemampuan memengaruhi perilaku secara etis dan bertanggung jawab menjadi kompetensi penting.

4. Membangun Hubungan yang Harmonis dan Saling Percaya antara Tenaga Kesehatan, Pasien dan Keluarga

Komunikasi efektif berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya. Hubungan yang dilandasi oleh komunikasi terbuka, empatik, dan saling menghargai akan menciptakan lingkungan interaksi yang kondusif. Kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi efektif menjadi modal utama dalam kerja sama jangka panjang.

5. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat

Komunikasi efektif mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Ketepatan keputusan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima serta kejelasan komunikasi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat dalam pengambilan keputusan profesional.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, komunikasi efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Komunikasi yang baik antara tenaga profesional dan pengguna layanan dapat meningkatkan kepuasan, keselamatan, serta hasil yang dicapai. Dengan demikian, komunikasi efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan mutu layanan.

C. Unsur-unsur komunikasi efektif

Beberapa unsur yang menjadi kunci dalam komunikasi efektif adalah:

1. Kejelasan: Informasi harus disampaikan secara jelas agar mudah dipahami oleh penerima.
2. Kelengkapan: Pesan harus mencakup semua informasi yang diperlukan agar tidak ada kebingungan.
3. Ketepatan: Pesan harus disampaikan dengan pilihan kata yang sesuai untuk menghindari kesalahpahaman.
4. Ketepatan Waktu: Komunikasi harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk memastikan penerima siap menerima pesan.
5. Timbal Balik: Umpan balik dari penerima penting untuk mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar.

D. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Komunikasi Efektif

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi antara lain:

1. Keterbukaan: Kesiapan penerima dan pengirim untuk terbuka terhadap ide dan informasi baru.
2. Empati: Kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain.
3. Budaya: Perbedaan budaya dapat memengaruhi cara pesan ditafsirkan.
4. Keterampilan Komunikasi: Tingkat keterampilan komunikasi individu, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada efektivitas pesan yang disampaikan.
5. Hambatan Fisik atau Teknologi: Masalah seperti gangguan sinyal dalam komunikasi elektronik atau ketidakmampuan mendengar dapat mempengaruhi pemahaman pesan.

6. Kejelasan Pesan: Pesan harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.
7. Kemampuan Komunikator: Pengirim pesan harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan efektif.
8. Persepsi Penerima: Bagaimana penerima menafsirkan pesan berdasarkan latar belakang, pengalaman, atau pengetahuan.
9. Kualitas Saluran: Media yang digunakan harus sesuai dengan jenis pesan (misalnya, komunikasi formal atau informal).
10. Gangguan (Noise): Gangguan fisik atau mental dapat mengurangi kejelasan dan efektivitas pesan.
11. Faktor Emosional: Emosi seperti marah atau stres dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi

E. Karakteristik dari Komunikasi Efektif

1. Terdapat Kesamaan Makna antara Komunikator dan Komunikan

Komunikasi efektif ditandai dengan adanya kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Artinya, pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima dan ditafsirkan oleh komunikan sesuai dengan maksud awal. Kesamaan makna ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik atau kekeliruan dalam bertindak. Penggunaan bahasa yang tepat, jelas, dan sesuai dengan latar belakang penerima pesan akan membantu tercapainya kesamaan makna.

2. Pesan Dapat Dipahami dengan Jelas

Indikator dari komunikasi efektif berikutnya adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh komunikan. Pesan yang jelas disusun secara sistematis, tidak berbelit-belit, dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Kejelasan pesan memungkinkan komunikan menangkap inti informasi tanpa kebingungan, sehingga komunikasi berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

3. Terjadi Umpan Balik yang Positif

Umpan balik atau feedback merupakan respons yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. Dalam komunikasi efektif, umpan balik bersifat positif dan konstruktif, baik dalam bentuk tanggapan verbal maupun nonverbal. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa komunikan memperhatikan, memahami, dan merespons pesan yang disampaikan. Umpan balik juga membantu komunikator mengetahui apakah pesan telah diterima dengan baik atau perlu diperjelas kembali.

4. Tidak Terdapat Hambatan yang Signifikan

Komunikasi yang efektif berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Hambatan komunikasi dapat berupa gangguan fisik, psikologis, bahasa, maupun perbedaan budaya. Apabila hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan atau diatasi, maka proses penyampaian pesan akan berjalan lebih lancar. Lingkungan yang kondusif dan sikap terbuka dari kedua belah pihak sangat mendukung terciptanya komunikasi yang efektif.

5. Komunikasi Menghasilkan Perubahan Sikap, Pengetahuan, atau Perilaku

Indikator utama komunikasi efektif adalah adanya dampak atau hasil nyata dari proses komunikasi tersebut. Komunikasi yang berhasil mampu memengaruhi sikap, menambah pengetahuan, atau mengubah perilaku komunikan sesuai dengan tujuan komunikasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa pesan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan diinternalisasi dengan baik oleh komunikan.

F. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mengupayakan Komunikasi efektif dalam tim kesehatan:

1. Sensifitas komunikan terutama hal pribadi paling baik dibicarakan secara langsung untuk mengurangi miskomunikasi.
2. Kesadaran dan pengertian terhadap makna simbolis yang disampaikan non verbal atau body language perlu disesuaikan dengan kultur.
3. Penentuan waktu yang tepat dan umpan balik
4. Komunikasi tatap muka memungkinkan tim untuk saling melihat lawan bicara, body language, mimik, serta menghilangkan terjadinya miskomunikasi
5. Komunikasi efektif dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh beberapa pihak, pasien, dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya (Noor Ariyani Rokhmah, Anggorowati, 2017)

G. Komunikasi dengan Keluarga Pasien

Keluarga pasien merupakan salah satu sasaran komunikasi kesehatan. Komunikasi efektif diharapkan terjadi terhadap keluarga pasien melalui petugas kesehatan. Komunikasi bertujuan mengirimkan informasi, pesan ataupun hiburan, pendidikan serta perubahan dapat terjadi jika proses komunikasi (metode persuasi) menunjukkan adanya komunikator, rancangan pesan, serta media (Santosa et al., 2020).

Berkomunikasi menjadi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan lain-lain. Komunikasi dapat terjadi jika pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses komunikasi (Santosa et al., 2020). Adanya kerja sama antar sesama manusia menjadi sangat penting karena pada dasarnya setiap orang tidak dapat untuk memenuhi hidupnya sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain yang dapat mendorong seseorang

untuk melakukan kerja sama dengan orang lain (Darmanto, 2020). Hal ini menunjukkan manusia butuh orang lain dalam setiap karya kerja bahkan pelayanannya.

Ketergantungan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain menjadi dasar penerapan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dorongan dari anggota keluarga/termasuk teman dekat juga mempengaruhi, agar seseorang akan menerima perilaku tertentu, serta kemudian diikuti saran atau nasehat, dan motivasi oleh keluarga ataupun kawan. Kemampuan tiap anggota keluarga atau kawan terdekat dapat berpengaruh pada seorang individu dalam berperilaku seperti yang diharapkan melalui pengalaman, pengetahuan, serta penilaian individu tersebut pada perilaku tertentu juga keyakinannya melihat keberhasilan orang lain seperti disarankan (Notoatmodjo, 2012). Kerjasama yang dilakukan dapat menunjang komunikasi terutama dengan keluarga pasien. Adanya sikap kooperatif dari keluarga sebagai bagian dari proses untuk membantu penyembuhan pasien.

H. Teknik-teknik Komunikasi Efektif Tenaga Kesehatan kepada Pasien dan Keluarga Pasien

Komunikasi merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan. Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga pasien berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepuasan pasien dan keluarganya. Melalui komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi medis dengan jelas, membangun kepercayaan, serta mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan.

1. Mendengarkan Aktif (Active Listening)

Mendengarkan aktif adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan perhatian penuh kepada pasien dan keluarga saat mereka menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun perasaan. Teknik ini melibatkan kontak mata, bahasa tubuh yang terbuka, serta tidak memotong pembicaraan. Dengan mendengarkan aktif, pasien merasa dihargai dan dipahami, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi penting terkait kondisi kesehatannya.

2. Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Mudah Dipahami

Tenaga kesehatan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu teknis saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Istilah medis yang sulit dipahami sebaiknya dijelaskan dengan bahasa awam. Penyampaian

informasi yang jelas membantu pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan, prosedur tindakan, serta rencana perawatan yang akan dilakukan.

3. Menunjukkan Empati dan Sikap Peduli

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kondisi emosional pasien serta keluarganya. Tenaga kesehatan perlu menunjukkan sikap empati melalui tutur kata yang lembut, sikap ramah, dan penghargaan terhadap perasaan pasien. Sikap empati dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kenyamanan pasien, dan menciptakan hubungan terapeutik yang positif.

4. Memberikan Informasi yang Jujur dan Transparan

Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi medis sangat penting dalam komunikasi kesehatan. Tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang akurat mengenai diagnosis, prosedur, risiko, dan prognosis dengan cara yang mudah dipahami. Transparansi informasi membantu pasien dan keluarga membuat keputusan yang tepat terkait perawatan yang dijalani.

5. Memberikan Umpan Balik dan Klarifikasi

Umpan balik dan klarifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah dipahami dengan benar oleh pasien dan keluarga. Tenaga kesehatan dapat meminta pasien mengulangi penjelasan singkat atau mengajukan pertanyaan klarifikasi. Teknik ini membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan keselamatan pasien.

6. Menyesuaikan Komunikasi dengan Kondisi Pasien dan Keluarga

Setiap pasien dan keluarga memiliki latar belakang pendidikan, budaya, dan kondisi emosional yang berbeda. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan gaya komunikasi, nada bicara, serta media penyampaian informasi sesuai dengan karakteristik penerima pesan. Penyesuaian ini akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan penerimaan informasi.

I. Prinsip-prinsip Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang dapat dipahami dengan benar oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Dalam berbagai konteks, baik pendidikan, organisasi, maupun pelayanan, komunikasi efektif menjadi kunci tercapainya tujuan bersama. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi efektif yang perlu dipahami dan diterapkan:

1. Kejelasan (Clarity)

Kejelasan berarti pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan tingkat pemahaman penerima. Komunikator harus menghindari penggunaan istilah yang ambigu, jargon

berlebihan, atau kalimat yang terlalu panjang. Pesan yang jelas akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi.

Beberapa cara untuk mencapai kejelasan dalam komunikasi:

- a. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ketika berbicara dengan pasien atau keluarga pasien.
- b. Menyusun pesan dengan struktur yang logis sehingga penerima dapat mengikuti informasi dengan mudah.
- c. Menghindari jargon medis yang tidak diperlukan, kecuali jika berbicara dengan sesama tenaga kesehatan

2. Ketepatan (Accuracy)

Ketepatan berkaitan dengan kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan. Data, fakta, dan istilah yang digunakan harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi yang akurat akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas komunikator, serta mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Beberapa contoh situasi di mana komunikasi tepat waktu sangat diperlukan:

- a. Menyampaikan hasil tes atau diagnosa penting kepada tim medis secepatnya.
- b. Memberikan informasi tentang perubahan kondisi pasien secara segera.
- c. Memastikan instruksi pengobatan segera dilaksanakan tanpa penundaan.

3. Kelengkapan (Completeness)

Pesan yang disampaikan harus lengkap dan mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan oleh penerima. Informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kebingungan, salah tafsir, atau tindakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, komunikator perlu memastikan bahwa pesan menjawab unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana jika diperlukan. Komunikasi yang efektif juga harus mencakup semua informasi yang relevan. Jika informasi yang diberikan tidak lengkap, hal ini bisa menyebabkan keputusan klinis yang tidak optimal atau tindakan yang salah. Informasi yang lengkap meliputi semua aspek penting dari kondisi pasien, termasuk riwayat medis, hasil tes, pengobatan yang sedang dilakukan, serta potensi risiko atau komplikasi. Misalnya, saat menyerahkan tugas antar shift (hand-off), tenaga medis harus memastikan bahwa seluruh informasi tentang kondisi pasien, perubahan yang terjadi, dan rencana perawatan disampaikan secara menyeluruh.

4. Kesopanan (Courtesy)

Kesopanan mencerminkan sikap hormat, etika, dan empati dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang santun, nada bicara yang baik, serta sikap menghargai lawan bicara akan menciptakan suasana komunikasi yang

positif. Kesopanan juga membantu menjaga hubungan baik dan mencegah konflik.

5. Konsistensi

Konsistensi berarti kesesuaian antara pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan. Pesan yang konsisten akan memperkuat pemahaman penerima dan menghindari kebingungan. Konsistensi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas komunikator.

6. Keterbukaan dan Saling Menghargai

Keterbukaan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, menerima masukan, dan menghargai perbedaan pendapat. Komunikasi yang efektif bersifat dua arah, di mana setiap pihak merasa dihargai dan didengar. Sikap saling menghargai akan membangun kepercayaan, kerja sama, dan hubungan yang harmonis.

7. Dipahami oleh Penerima

Komunikasi yang efektif harus memastikan bahwa pesan dapat mudah dipahami oleh penerima, baik itu pasien, keluarga, atau rekan sejawat. Penting untuk menghilangkan potensi kesalahan atau kesalahpahaman, sehingga informasi yang diterima benar-benar sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim.

Beberapa cara untuk memastikan hal ini adalah:

- a. Konfirmasi pemahaman: Ajukan pertanyaan kepada penerima untuk memverifikasi bahwa mereka memahami pesan yang telah disampaikan. Misalnya, dokter dapat meminta pasien untuk mengulangi instruksi pengobatan.
- b. Teknik teach-back: Gunakan teknik teach-back di mana penerima diminta untuk menjelaskan kembali apa yang mereka pahami dari pesan yang disampaikan, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan interpretasi.
- c. Umpan balik langsung: Dorong penerima untuk memberikan umpan balik jika ada bagian dari pesan yang kurang jelas atau membingungkan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh bagaimana komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima dapat diterapkan dalam sebuah situasi klinis:

- a. Situasi: Seorang pasien yang baru saja menjalani operasi mengalami perubahan kondisi seperti peningkatan tekanan darah secara drastis.

- b. Tepat Waktu: Perawat segera menginformasikan perubahan ini kepada dokter bedah yang bertanggung jawab, tanpa menunda untuk menunggu jadwal shift berikutnya.
- c. Akurat: Perawat menyampaikan angka tekanan darah yang akurat, riwayat medis terbaru, serta gejala lain yang muncul, berdasarkan catatan medis dan observasi terkini.
- d. Lengkap: Perawat juga menyampaikan informasi tentang obat yang terakhir diberikan kepada pasien dan riwayat kondisi sebelumnya yang bisa relevan dengan peningkatan tekanan darah.
- e. Jelas: Perawat menggunakan bahasa yang jelas dan memastikan bahwa tidak ada ambiguitas dalam deskripsi kondisinya, serta menggunakan protokol komunikasi terstruktur seperti SBAR.

J. Contoh Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan, Pasien dan Keluarga Pasien

Komunikasi efektif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan layanan, serta membangun kepercayaan. Berikut beberapa contoh komunikasi efektif yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan.

1. Contoh Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan dan Pasien

Contoh 1:

Penjelasan Tindakan Medis Tenaga Kesehatan:

"Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu agak tinggi. Kami akan memberikan obat untuk membantu menurunkannya. Obat ini diminum satu kali sehari setelah makan. Apakah Ibu ada alergi obat sebelumnya?"

Pasien:

"Tidak ada, Bu."

Tenaga Kesehatan:

"Baik, jika setelah minum obat muncul pusing atau mual, segera beri tahu kami ya, Bu."

Penjelasan:

Komunikasi ini jelas, menggunakan bahasa sederhana, dan memastikan pasien memahami kondisi serta tindakannya.

Contoh 2:

Edukasi Perawatan Mandiri Tenaga Kesehatan:

"Bapak perlu menjaga pola makan rendah garam dan rutin kontrol setiap bulan. Saya akan tuliskan jadwal kontrolnya. Apakah Bapak ingin saya jelaskan kembali?"

Pasien:

"Iya, tolong dijelaskan lagi."

Penjelasan:

Tenaga kesehatan bersikap terbuka, sabar, dan memastikan informasi dipahami pasien.

2. Contoh Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan dan Keluarga Pasien

Contoh 1:

Penyampaian Kondisi Pasien Tenaga Kesehatan:

"Bapak/Ibu, kondisi pasien saat ini stabil, namun masih memerlukan pemantauan selama 24 jam. Kami mohon kerja sama keluarga untuk membatasi jumlah penunggu demi kenyamanan pasien."

Keluarga:

"Baik, kami mengerti."

Penjelasan:

Informasi disampaikan lengkap, sopan, dan disertai alasan yang jelas.

Contoh 2:

Persiapan Tindakan Medis Tenaga Kesehatan:

"Sebelum tindakan dilakukan, kami mohon persetujuan keluarga. Tindakan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasien. Apakah ada yang ingin ditanyakan?"

Keluarga:

"Tidak, sudah jelas."

Penjelasan:

Tenaga kesehatan memberi kesempatan keluarga bertanya dan menunjukkan sikap menghargai.

3. Contoh Komunikasi Efektif antara Pasien dan Keluarga Pasien

Contoh:

Pasien:

"Saya merasa lebih tenang setelah dijelaskan oleh perawat. Tolong bantu saya mengingat jadwal minum obat ya."

Keluarga:

"Baik, kami akan membantu dan menemani kontrol sesuai jadwal."

Penjelasan:

Terjadi komunikasi dua arah yang mendukung proses penyembuhan pasien.

K. Simpulan

Komunikasi efektif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Komunikasi yang dilakukan secara jelas, akurat, lengkap, sopan, konsisten, serta dilandasi sikap keterbukaan dan saling menghargai akan membantu memastikan bahwa informasi medis dapat dipahami dengan benar oleh seluruh pihak yang terlibat.

Melalui komunikasi yang efektif, tenaga kesehatan dapat menjelaskan kondisi pasien, rencana perawatan, serta tindakan medis secara profesional dan empatik, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga. Di sisi lain, pasien dan keluarga memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, serta pertanyaan secara terbuka, yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat.

Dengan demikian, penerapan komunikasi efektif tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kepuasan pasien, pencegahan kesalahan medis, serta tercapainya tujuan asuhan kesehatan yang holistik dan berkesinambungan.

L. Referensi

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Betancourt, J. R., Green, A. R., Carrillo, J. E., & Owusu Ananeh-Firempong, O. (2016). *Defining cultural competence*. The Commonwealth Fund.
- Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). The benefits of health information technology. *Health Affairs*, 30(3), 464–471.
- Campinha-Bacote, J. (2019). *The process of cultural competence in the delivery of healthcare services* (8th ed.). Springer.
- Elwyn, G., et al. (2012). Shared decision making. *BMJ*, 344, e256.
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). *Patient-centered communication*. National Cancer Institute.
- Hall, J. A., Horgan, T. G., & Murphy, N. A. (2015). *Nonverbal communication*. Psychology Press.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm*. National Academies Press.
- Joint Commission. (2016). *Sentinel event data root causes*. Joint Commission.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Keselamatan Pasien Rumah*

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar kompetensi tenaga kesehatan. Kemenkes RI.
- Knapp, M. L., Hall, J. A., & Horgan, T. G. (2014). Nonverbal communication in human interaction (8th ed.). Cengage.
- Laidsaar-Powell, R. C., et al. (2018). Family involvement in care. *Psycho-Oncology*, 27(5), 1225–1232.
- London: CRC Press.
- Nursalam. (2020). Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Organization.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of Nursing*. St. Louis: Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Profesional. Jakarta: Salemba Medika.
- Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Sartika. Rika., Sidaria. (2024). *Komunikasi Dasar Keperawatan Panduan untuk Profesional Kesehatan*. Andalas University Press. Padang
- Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (2016). *Skills for Communicating with Patients*.
- WHO. (2017). *Communicating effectively with patients*. World Health
- World Health Organization. (2017). *Patient safety: Global action*. WHO.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline on digital health interventions*. WHO.
- World Medical Association. (2018). *Declaration of Lisbon on the rights of the patient*.

M. Glosarium

Asuhan interdisiplin/interprofesional: Pelayanan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif.

Beban kerja: Banyaknya tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan yang dapat membatasi waktu komunikasi dengan pasien/keluarga.

Communication barrier (hambatan komunikasi): Faktor yang mengganggu penyampaian/pemahaman pesan, misalnya emosi, perbedaan budaya, gangguan fisik, atau keterbatasan waktu.

Empati: Kemampuan memahami perasaan dan perspektif pasien/keluarga serta mengekspresikan kepedulian secara verbal maupun nonverbal.

Feedback (umpan balik): Respons penerima pesan yang menunjukkan apakah informasi dipahami; membantu komunikator memperbaiki/menegaskan pesan.

Hand-off (serah terima): Proses pengalihan tanggung jawab perawatan pasien antar petugas/shift yang membutuhkan komunikasi lengkap dan jelas.

Intonasi: Variasi tinggi-rendah dan penekanan suara yang memengaruhi cara pesan diterima (misalnya terdengar tegas, hangat, atau mengancam).

Kepatuhan (adherence): Kesiediaan pasien mengikuti rencana terapi (minum obat, kontrol, diet); dipengaruhi kualitas komunikasi dan pemahaman pasien.

Literasi kesehatan: Kemampuan pasien/keluarga memahami informasi kesehatan; memengaruhi cara komunikasi harus disesuaikan.

Mediator keluarga: Peran keluarga membantu menerjemahkan, menguatkan, atau menyampaikan kembali pesan tenaga kesehatan kepada pasien.

Noise (gangguan): Hal yang menghambat komunikasi, bisa fisik (bising), teknis (sinyal buruk), atau psikologis (cemas, marah).

Patient-centered communication (komunikasi berpusat pada pasien): Pendekatan yang menghargai nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien serta melibatkan pasien aktif dalam perawatan.

Regulasi/standar hak pasien: Ketentuan yang menegaskan pasien berhak mendapat informasi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami tentang kondisinya.

SBAR: Protokol komunikasi terstruktur: Situation (situasi), Background (latar belakang), Assessment (penilaian), Recommendation (rekomendasi) untuk komunikasi klinis yang jelas.



PROFIL PENULIS



apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm Lahir di Pematang siantar, 01 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Indonesia tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah mengampu mata kuliah bidang teknologi Farmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmadst121@gmail.com



M. Noor Ifansyah, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Martapura Kalimantan Selatan pada tanggal 17 November 1991. Saat ini penulis tinggal dan bekerja di Martapura. Pendidikan Tinggi dimulai dari Diploma Tiga Keperawatan di Akademi Keperawatan Intan Martapura (Lulus 2012), kemudian Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) (Lulus 2016), dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Studi Magister Keperawatan Peminatan keperawatan Komunitas di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) (Lulus 2019).

Penulis saat ini bekerja di Stikes Intan Martapura sebagai Dosen Tetap. Selain menjadi dosen, penulis juga mendapat tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pusat Karir Stikes Intan Martapura. Penulis juga aktif di berbagai organisasi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Banjar, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banjar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banjar dan Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga aktif dalam penulisan beberapa buku dan artikel ilmiah tentang penelitian dan pengabdian Masyarakat terutama tentang Keperawatan Komunitas.

Email penulis: ifans.ners@gmail.com



PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Supriadi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di PSIK FK Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Komunitas di FIK Universitas Indonesia Jakarta, dan Pendidikan Doktoral Bidang Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sejak tahun 1988 sebagai dosen dengan fokus pada bidang keperawatan Komunitas, Keluarga, dan Gerontik. Penulis juga aktif sebagai peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, penulis buku serta nara sumber terkait pengembangan keperawatan kesehatan masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: supriadifalah@gmail.com

Motto: "Terus belajar meski lelah, karena mimpi butuh usaha."

Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes. Lahir di Karanganyar, 21 April 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi DIV Bidan Pendidik, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai bidan pelaksana di PMB. Saat ini penulis bekerja di Universitas Respati Yogyakarta mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Kebidanan, Keterampilan Dasar Praktik kebidanan Lanjut, Bahasa Inggris Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maratusholikhah@respati.ac.id

Motto: "Doa tanpa usaha adalah angan-angan, usaha tanpa doa adalah kesombongan"



PROFIL PENULIS



Dr. Herta Masthalina, S. KM., M.PH. Peneliti dan pengajar pada Kemenkes Poltekkes Medan Jurusan Gizi. Lahir di Belawan 23 Agustus 1974. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Belawan. Kemudian pada tahun 1992- 1995 melanjutkan studi DIII Gizi di PAM (Pendidikan Ahli Madya Gizi) Lubuk Pakam, melanjutkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga tahun 2001 - 2003 dan mengambil Magister of Public Health tahun 2008-2010 di Universitas Gadjah Mada dan lulus Doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Penulis memulai karirnya sebagai asisten dosen di PAM Gizi Mataram tahun 1998, menjadi dosen pada Poltekkes Mataram tahun 2003-2014, dosen di Poltekkes Medan tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini mengajar mata kuliah Penilaian Status Gizi, Epidemiologi Gizi, Program Pangan dan Gizi, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi dan dipublikasi dalam jurnal internasional maupun nasional. Berperan serta dalam menyumbangkan pikiran dan kegiatan ilmiah dalam penurunan stunting di Sumatera Utara, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat dan Gizi



Nur Aini Fatimah, S.Kom., M.Kes. Lahir di Kediri, 02 Mei 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Manajemen Informatika lulus tahun 2004 dan melanjutkan S1 pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Merdeka Malang (tahun 2007–2009). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKes Surya Mitra Husada Kediri (tahun 2016-2018). Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di STIKes Satria Bhakti Nganjuk. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar.

Motto: "Bersyukur untuk setiap harinya. Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hal terbaik yang diberikan oleh Allah SWT."

 [googlescholar.ID: iuycP4AAAAJ](#);  [SintaID: 6665951](#)

E-mail: nice.rani07@gmail.com

Sinopsis

“Bunga Rampai Pelayanan Kesehatan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan” merupakan kumpulan tulisan yang mengangkat pendekatan patient- and family-centered care sebagai fondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern. Bunga Rampai ini menegaskan bahwa pasien bukan lagi objek pelayanan, melainkan subjek utama yang memiliki hak, nilai, dan preferensi dalam proses perawatan. Pada saat yang sama, keluarga dipandang sebagai mitra strategis karena berperan besar dalam dukungan emosional, pengambilan keputusan, kepatuhan terapi, serta kesinambungan perawatan dari fasilitas kesehatan hingga rumah.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami prinsip-prinsip pelayanan berbasis pasien dan keluarga, seperti komunikasi terbuka dan empatik, penghormatan terhadap pilihan pasien, pemberdayaan keluarga, pengambilan keputusan bersama, serta kolaborasi interprofesional yang terintegrasi. Berbagai praktik baik dan strategi aplikatif disajikan untuk membantu tenaga kesehatan menerapkan pendekatan ini dalam situasi klinis yang beragam, termasuk menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, perbedaan budaya, variasi literasi kesehatan, serta dinamika emosional pasien dan keluarga.

Bunga Rampai ini ditujukan bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan—perawat, bidan, dokter, farmasis, nutrisisionis, tenaga promosi kesehatan, serta pengelola layanan—sebagai referensi pembelajaran dan penguatan praktik profesional. Dengan pendekatan yang kontekstual dan mudah diterapkan, buku ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien, pengalaman pasien dan keluarga, serta membangun budaya pelayanan kesehatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpusat pada kebutuhan individu serta keluarganya.

“Bunga Rampai Pelayanan Kesehatan Berbasis Pasien dan Keluarga dalam Praktik Tenaga Kesehatan” merupakan kumpulan tulisan yang mengangkat pendekatan patient- and family-centered care sebagai fondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern. Bookchapter ini menegaskan bahwa pasien bukan lagi objek pelayanan, melainkan subjek utama yang memiliki hak, nilai, dan preferensi dalam proses perawatan. Pada saat yang sama, keluarga dipandang sebagai mitra strategis karena berperan besar dalam dukungan emosional, pengambilan keputusan, kepatuhan terapi, serta kesinambungan perawatan dari fasilitas kesehatan hingga rumah.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami prinsip-prinsip pelayanan berbasis pasien dan keluarga, seperti komunikasi terbuka dan empatik, penghormatan terhadap pilihan pasien, pemberdayaan keluarga, pengambilan keputusan bersama, serta kolaborasi interprofesional yang terintegrasi. Berbagai praktik baik dan strategi aplikatif disajikan untuk membantu tenaga kesehatan menerapkan pendekatan ini dalam situasi klinis yang beragam, termasuk menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, perbedaan budaya, variasi literasi kesehatan, serta dinamika emosional pasien dan keluarga.

Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan—perawat, bidan, dokter, farmasis, nutrisisionis, tenaga promosi kesehatan, serta pengelola layanan—sebagai referensi pembelajaran dan penguatan praktik profesional. Dengan pendekatan yang kontekstual dan mudah diterapkan, buku ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan, keselamatan pasien, pengalaman pasien dan keluarga, serta membangun budaya pelayanan kesehatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpusat pada kebutuhan individu serta keluarganya.

ISBN 978-634-7556-81-3



9

786347

556813

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

